ANÁLISIS DE EMPRESA COTIZADA

The Ensign Group, Inc.

ENSG · Nasdaq Global Select Market · ISIN US29358P1012 · Salud

Fecha de corte de los datos: **20 oct 2026** · Divisa: **USD** · Cifras en **millones**

Recomendación **Mantener**	Precio **173,05 USD**	Objetivo 12 m **170,30 USD**	Rentabilidad 12 m **-1,4 % (base +6,4 %)**
Valor intrínseco **92,27 USD · mercado 104,10**	Convicción **Media**	Capitalización **10.296 M**	EV/EBITDA próx. 12 m **n.d.**
Deuda neta aj. / EBITDA **-0,2x**			

Nombre	**The Ensign Group, Inc.**	Ticker / ISIN	**ENSG / US29358P1012**
Mercado	**Nasdaq Global Select Market**	Índice de referencia	**S&P MidCap 400**
Sector / industria	**Salud / Centros y servicios sanitarios**	Sede · fundación	**San Juan Capistrano (California) · 1999**
Empleados	**56.000**	Web	**https://www.ensigngroup.net**
Precio (fecha)	**173,05 (19 oct 2026)**	Rango 52 semanas	**141,58 – 218,00**
Acciones diluidas (M)	**59,5**	Free float	**96,0 %**
Capitalización	**10.296 M USD**	Valor empresa	**10.177 M USD**
Volumen medio diario	**≈ 63 M USD/día (3 meses)**	Próximos resultados	**2 nov 2026**

Contenido

- Síntesis y recomendación (una página)
- Resumen ejecutivo
- Parte I — Negocio y sector: 1. Historia · 2. Modelo de negocio · 3. Sector y mercado · 4. Posición competitiva
- Parte II — Finanzas: 5. Cuenta de resultados · 6. Resultados recientes · 7. Balance y circulante · 8. Flujos de caja · 9. Calidad contable · 10. Rentabilidad · 11. Deuda y solvencia · 12. Asignación de capital
- Parte III — Equipo y gobierno: 13. Equipo directivo · 14. Gobierno corporativo
- Parte IV — Mercado y valoración: 15. Consenso · 16. Bolsa · 17. Múltiplos históricos · 18. Comparables · 19. Transacciones · 20. DCF · 21. Escenarios · 22. Suma de partes · 23. Síntesis
- Parte V — Tesis, riesgos y seguimiento: 24. Catalizadores · 25. Riesgos y pre-mortem · 26. ESG · 27. Preguntas abiertas · 28. Sentimiento en foros y comentarios
- Anexos: controles de calidad, información no disponible y fuentes
- Las secciones sin información verificable no se imprimen; quedan listadas en el anexo «Información no disponible».

No constituye recomendación de inversión.

Síntesis y recomendación

Mantener · Convicción Media · Objetivo a 12 meses **170,30 USD** frente a 173,05 · Rentabilidad a 12 meses **-1,4 % (base +6,4 %)** · Valor intrínseco 92,27 USD · con la prima implícita del mercado: 104,10 (-39,8 %) · Alcista / bajista -46,6 % / -72,1 %

The Ensign Group gestiona 398 residencias y centros de cuidados en 17 estados de EE. UU. (sobre todo Arizona, California y Texas): cuidados de enfermería y rehabilitación tras una hospitalización y vida asistida, más una inmobiliaria propia, Standard Bearer, dueña de 177 inmuebles [1, 2]. Facturó 5.487 M USD en los últimos 12 meses con un EBITDA de 582 M y un BPA GAAP de 6,38 USD [2, 10]. Crece rápido (+16,6 % previsto para 2026) comprando residencias con problemas y arreglándolas, y lleva años subiendo la guía: tres veces en 2026 [3].

La calidad pasa. El ROIC del motor es del 18,9 % frente a un WACC del 9,8 % (+9,1 puntos) y el crecimiento es sostenible: el mercado crece ≈ 6 % y Ensign tiene el 2,3 % [11]. Con dos matices: el capital no incluye ≈ 1.990 M de arrendamientos (con ellos, ROIC ≈ 11 %) y el ROIC baja desde el 25 % de 2020 porque ahora compra inmuebles.

La valoración no. El DCF da 81,60 USD (−52,8 %) y los escenarios 48-92 USD: el flujo después de compras es casi nulo y el precio solo se explica si las compras siguen rindiendo muy por encima del coste de capital durante una década. La regla a 12 meses, con un PER de 22,5 veces sobre un BPA GAAP de 2028e de 8,17 USD, da un objetivo base de 183,83 USD (+6,4 %) y ponderado de 170,30 (−1,4 %): Mantener. Señal de venta por encima de 189,51 USD.

Los riesgos son regulatorios y concretos. Medicaid paga el 45 % de las ventas y la OBBB recorta los pagos dirigidos un 10 % al año desde 2028 y obliga a revisar la elegibilidad cada 6 meses desde 2027; Medicare (24 %) puede recortar el «case-mix creep». La plantilla mínima federal se derogó, pero el personal es el 60 % de los gastos. En junio, Hunterbrook y Muddy Waters publicaron informes bajistas (plantilla insuficiente, licencias de administradores) y la acción cayó un 16 % en un mes; ningún regulador ha actuado y la empresa respondió con recompras, pero hay una demanda colectiva y un CID del DOJ abierto desde 2024. El riesgo de IA es bajo y mixto (ayuda en lo administrativo; los algoritmos de las aseguradoras acortan estancias).

Regla 13: no cambia; no hay hecho pendiente con fecha que mueva el precio más de un 5 %. El valor intrínseco del informe (DCF, escenarios y comparables) es de 92,27 USD, un 47 % bajo el precio.

Convicción media: las dos reglas (absoluta y relativa) y la de 12 meses coinciden en no comprar y el precio está lejos de los umbrales (venta por encima de 189,51; compra solo por debajo de 92), pero el negocio es bueno y el BPA podría sorprender al alza otra vez. Subiría la convicción una actuación regulatoria por los informes bajistas o recortes de Medicaid ya concretados (hacia Vender); la bajaría una guía de 2027 muy fuerte con compras al ritmo de 2026. Conclusión: buena empresa, cara. Mantener, sin posición nueva.

Resumen ejecutivo

Recomendación: Mantener · Convicción: Media · Horizonte: 12 meses · Objetivo a 12 meses: **170,30 USD** (rentabilidad -1,4 % (base +6,4 %)) · Valor intrínseco: 92,27 USD (-46,7 % sobre 173,05) · con la prima implícita del mercado: 104,10 (-39,8 %)

Ensign es el mejor operador de residencias de EE. UU. por historial (20 años creciendo con ROIC alto) y por modelo (centros autónomos, compras pequeñas y baratas). Pero a 173 USD el precio ya paga muchos años de compras rentables: el DCF da 82 USD y la regla a 12 meses, con el PER de su propia historia, solo un +6 % base. Con Medicaid como primer pagador y recortes ya legislados, no hay margen de seguridad.

La decisión

Elemento de la decisión	Valor
Objetivo a 12 meses (nuestro PER × nuestro BPA 2028e, ponderado 25/50/25)	170,30 USD
Bajista / base / alcista a 12 meses	18,0x × 6,48 = 116,64 · 22,5x × 8,17 = 183,83 · 22,5x × 8,75 = 196,88
Rentabilidad a 12 meses: ponderada / del base (con dividendo)	-1,4 % / 6,4 %
Regla de múltiplos aplicada	v3: base a mitad de camino hacia la mediana adelantada, sin alejarse del actual más de ×1,1; bajista mín. 5 a (adelantado) o base × 0,80; alcista techo base × 1,35 (selector de método: sin marcas: decide la v3)
Objetivo medio de los analistas (solo contraste)	220,00 (nuestro base -16,4 %)
Valor intrínseco (síntesis ponderada, largo plazo)	92,27 USD
Potencial sobre el precio actual	-46,7 %
Rentabilidad por dividendo ordinario	0,2 %
Rentabilidad total esperada a 12 meses	-46,5 %
Escenario alcista / bajista	-46,6 % / -72,1 %
Asimetría (ganancia alcista / pérdida bajista)	-0,65x
Rentabilidad anual implícita en el precio frente al WACC y al que pide el mercado	6,4 % frente a 9,8 % y 8,8 %
Valor objetivo con la prima implícita del mercado (4,2 %, WACC 8,8 %)	104,10 USD
Rentabilidad total esperada con la prima del mercado	-39,7 %
Asimetría con la prima del mercado	-0,54x
Regla absoluta (frente a su coste de capital)	Vender
Regla relativa (frente a lo que pide el mercado)	Vender
Crecimiento anual implícito en el precio (2027e-2033e) frente al previsto para su mercado	31,4 % frente a 6,0 %
¿La calidad de la empresa sostiene el crecimiento previsto?	Sí (8,4 % anual proyectado; financiable al ROIC actual: 11,4 %)
Señal del valor intrínseco (regla del DCF, referencia)	Vender
Recomendación según la regla a 12 meses (Comprar: ponderada ≥ 15 %, base ≥ 12 % y valor intrínseco ≥ precio; Vender: ponderada ≤ -10 %)	Mantener
Convicción según los criterios (Mantener con las dos reglas de acuerdo y lejos de los umbrales)	Media

Regla (método v2): la recomendación sigue al objetivo a 12 meses, que es nuestro PER × nuestro BPA del ejercicio que mirará el mercado dentro de un año, con la misma regla de múltiplos para todas las empresas (base: el menor entre el PER actual y la mediana de 5 años; bajista: el mínimo de 5 años, o el base −15 % si ya cotiza por debajo; alcista: la media histórica o la de los comparables, sin pasar de base +30 %), ponderado con las probabilidades de los escenarios. Comprar si la rentabilidad ponderada es ≥ 15 %, la del base ≥ 12 % y el valor intrínseco no queda por debajo del precio; Vender si la ponderada es ≤ −10 %; Mantener en el resto. El consenso de analistas solo se compara. El valor intrínseco (DCF) es la referencia a largo plazo; su regla, la de siempre: Comprar si la rentabilidad total esperada a 12 meses es ≥ 15 % y el alcista gana al menos lo que pierde el bajista; Vender si es ≤ −10 %, o negativa con asimetría < 0,5; Mantener en el resto. Se aplica dos veces: con el WACC del análisis (regla absoluta: ¿rinde más que su coste de capital?) y con el WACC que resulta de la prima de riesgo implícita del mercado (regla relativa: ¿rinde más que lo que hoy pide el mercado, ajustado por su beta?). Manda la relativa, salvo que las dos se contradigan (una Comprar y otra Vender): entonces, Mantener.

Acción	A qué precio
Comprar	Por debajo de 92,27 (ponderada a 12 meses ≥ 15 %, base ≥ 12 % y precio ≤ valor intrínseco)
Mantener	Entre 92,27 y 189,51
Vender o reducir	Por encima de 189,51 (ponderada a 12 meses ≤ -10 %)

Qué cambiaría la recomendación

- Precio por debajo del valor intrínseco (92,27 USD): Comprar, si la regla a 12 meses sigue dando ≥ 15 % ponderada y ≥ 12 % base.
- Precio por encima de 189,51 USD: Vender (ponderada ≤ −10 %).
- Un expediente regulatorio federal por los informes bajistas: rehacer el informe.
- Recorte de tarifas de Medicaid de más de un 3 % en un estado grande: rebajar el BPA.
- Compras que se frenan (menos de 15 operaciones al año): rebajar el crecimiento y el múltiplo.

Dónde discrepamos del mercado

Lo que descuenta el precio.

Que Ensign seguirá comprando centros y subiendo la guía muchos años, con un objetivo medio de 220 USD (≈ 25 veces el BPA ajustado de 2027).

Lo que creemos nosotros.

Compartimos la calidad, pero el valor real (92,27 USD; 104,10 con la prima del mercado) está muy por debajo del precio y el PER de la propia historia solo da +6 % base a 12 meses.

Por qué podemos tener razón.

Los analistas valoran por múltiplos del historial; el DCF muestra que el flujo después de compras es casi nulo y que la OBBB recorta Medicaid desde 2027-2028.



Método	Valor por acción	Potencial	Peso
DCF	81,60	-52,8 %	50 %
Comparables (mediana EV/EBITDA y PER)	143,42	-17,1 %	20 %
Escenarios ponderados	75,94	-56,1 %	30 %

A favor

- **Historial**: 20 años creciendo, guía subida tres veces en 2026; ocupación del 82,9 % y mezcla de Medicare al alza [3].
- **Calidad**: ROIC del 18,9 % frente a un WACC del 9,8 % y deuda casi nula (caja neta de 123 M) [2].
- **Mercado**: el envejecimiento hace crecer la demanda y el sector está fragmentado (cuota del 2,3 %) [11].
- **Regulación de personal**: plantilla mínima federal derogada y aplazada hasta 2034 [2, 14].

- **Standard Bearer**: 177 inmuebles propios que bajan la dependencia de los alquileres [2].

En contra

- **Valor real**: DCF de 81,60 USD, un 53 % bajo el precio; ni el escenario alcista llega a 93.
- **Medicaid**: 45 % de las ventas, con recortes de la OBBB desde 2027-2028 [2].
- **Informes bajistas y CID del DOJ**: incertidumbre legal sin fecha de cierre [2, 25].
- **Arrendamientos**: con ≈ 1.990 M de alquileres como deuda, el ROIC baja a ≈ 11 % [2].
- **Directivos**: venden 13,6 M en 12 meses y no compran [20].

Qué tiene que pasar para que la tesis funcione

Las tarifas de Medicaid de California, Texas y Arizona y cómo aplican los estados la OBBB; la propuesta de Medicare de FY28 (abril de 2027); cualquier actuación regulatoria a partir de los informes bajistas; y el margen EBITDA trimestral (personal).

Indicadores de seguimiento

Indicador	Nivel actual	Umbral de alerta	Por qué importa
BPA ajustado (guía 2026)	7,75-7,85 USD	< 7,75 USD	Base de la regla a 12 meses.
Ocupación total	82,9 % (2T26)	< 81 %	Motor del crecimiento orgánico.
Margen EBITDA	10,9 % (1S26)	< 10 %	Coste de personal frente a tarifas.
Peso de Medicaid en las ventas	45,2 %	Recorte de tarifas en CA, TX o AZ	OBBB.
Operaciones nuevas al año	46 (2025); 23 (1S26)	< 15	Crecimiento inorgánico.

Datos clave

EV/EBITDA últimos 12 m / próx. 12 m	**17,5x / n.d.**	PER últimos 12 m / próx. 12 m	**27,1x / 20,5x**
EV/EBIT últimos 12 m	**21,8x**		
EV/Ventas últimos 12 m	**1,85x**	Rentabilidad por FCF	**4,1 %**
Rentabilidad por dividendo	**0,2 %**	Crecimiento anual de ingresos (2020-2025)	**16,1 %**
Margen EBITDA últimos 12 m	**10,6 %**	ROIC último ejercicio	**18,9 %**
WACC	**9,8 %**	Deuda neta / EBITDA (contable · ajustada)	**-0,2x · -0,2x**
Gobierno (criterios cumplidos)	**10 de 13 (1 sin dato)**		

Parte I — Negocio y sector

1. Historia e hitos

Confianza: Media

Ensign nació en 1999 en California, fundada por Roy Christensen y su hijo Christopher con la idea de comprar residencias con problemas y darles autonomía local [1]. Salió a bolsa en el Nasdaq en 2007. En 2014 escindió sus inmuebles en CareTrust REIT, y en octubre de 2019 su negocio de cuidados en casa, hospicio y vida asistida en The Pennant Group [1]. En 2019 Barry Port sustituyó a Christopher Christensen como consejero delegado, y en septiembre de 2025 asumió también la presidencia cuando Christensen se retiró [1]. Desde 2022 los inmuebles propios están en Standard Bearer, una REIT cautiva. Ha pasado de 245 operaciones en 2021 a 398 en 2026 [1, 3].

Año	Hito
1999	Fundación en California por la familia Christensen.
2007	Salida a bolsa en el Nasdaq.
2014	Escisión de los inmuebles en CareTrust REIT.
2019	Escisión de The Pennant Group (cuidados en casa, hospicio, vida asistida); Barry Port, consejero delegado.
2022	Standard Bearer Healthcare REIT agrupa los inmuebles propios.
2024	Acuerdo de 48 M USD por el caso de directores médicos; CID del Departamento de Justicia sobre facturación en Texas.
2025	46 operaciones nuevas; Christopher Christensen se retira y Port preside el consejo.
2026	Informes de Hunterbrook y Muddy Waters (junio); 20 centros comprados en Texas; línea de crédito de 800 M.

2. Modelo de negocio

Confianza: Alta

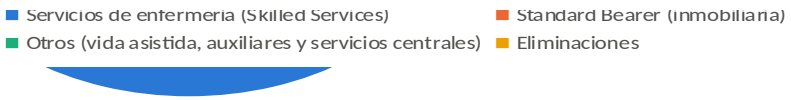
Ensign es el mayor operador cotizado de residencias de cuidados especializados («skilled nursing facilities», SNF) de EE. UU. por número de centros: 398 operaciones en 17 estados a julio de 2026, 32 de ellas con vida asistida en el mismo campus [3]. Atiende sobre todo a dos tipos de paciente: el de corta estancia que sale del hospital y necesita rehabilitación o cuidados de enfermería (pagado por Medicare o por seguros privados de Medicare Advantage) y el residente de larga estancia con dependencia, pagado mayoritariamente por Medicaid [1]. Cada centro es una filial con su propio director y su plantilla; un «Service Center» central da contabilidad, nóminas, sistemas y compras, y una filial cautiva asegura la responsabilidad profesional [1]. Desde 2022 los inmuebles propios están en Standard Bearer, una REIT cautiva que alquila a los centros de Ensign y a terceros (177 inmuebles a junio de 2026) [3]. La empresa crece comprando centros con malos resultados y mejorándolos: 102 operaciones nuevas desde 2024 [3].

Cómo gana dinero

Cobra por día de estancia: en el 2T26 la tarifa media de enfermería fue de 435 USD/día, 822 USD con Medicare, 609 con seguros privados y 314 con Medicaid [3]. El margen depende de tres cosas: la ocupación (82,9 % en el 2T26), la mezcla de pacientes de alta complejidad (50 % de los ingresos de enfermería) y el coste de personal, que es alrededor del 60 % de todos los gastos [1, 3]. El alquiler de los centros arrendados es el segundo coste fijo (239 M en 2025, el 4,7 % de las ventas) [1]. Hay apalancamiento operativo: con la plantilla mínima cubierta, cada punto de ocupación adicional deja mucho margen. Por eso un centro comprado con el 70 % de ocupación tarda dos o tres años en llegar al margen de los maduros. Ingresos casi sin estacionalidad (algo más en invierno por las gripes) [1].

Segmentos (2025)

Segmento	Ingresos	% del total	Crecimiento	Margen	Tipo de margen
Servicios de enfermería (Skilled Services)	4.838	95,7 %	+18,7 %	12,7 %	EBIT
Standard Bearer (inmobiliaria)	127	2,5 %	+33,4 %	29,6 %	EBIT
Otros (vida asistida, auxiliares y servicios centrales)	233	4,6 %	+20,7 %	-84,8 %	EBIT
Eliminaciones	-140	-2,8 %	+33,9 %	0,0 %	EBIT



Ingresos por segmento	2021	2022	2023	2024	2025
Servicios de enfermería (Skilled Services)	2.523	2.906	3.579	4.077	4.838
Standard Bearer (inmobiliaria)	58	73	83	95	127
Otros (vida asistida, auxiliares y servicios centrales)	103	123	156	193	233
Eliminaciones	-57	-76	-88	-104	-140



Clientes, recurrencia y poder de precios

El «cliente» es el pagador público o privado de cada estancia. En el 2T26 Medicaid supuso el 39,6 % de los ingresos de servicios, Medicare el 23,7 % y Medicaid de cuidados especializados el 5,6 %: el 68,9 % depende de programas públicos; seguros privados de Medicare Advantage y otros («managed care») el 18,5 % y privados y otros el 12,6 % [3]. Por días, Medicaid es el 58,6 % de las estancias de enfermería [3]. No hay contratos de duración: las tarifas de Medicare las fija CMS cada año (+3,2 % para el año fiscal 2026 y +2,4 % para 2027) y las de Medicaid cada estado [2]. El poder de precio es limitado y regulado; la empresa lo compensa con mezcla (más pacientes de Medicare y seguros, con tarifas de 609-822 USD/día frente a 314 USD de Medicaid) [3].

Indicadores operativos

Indicador	Anterior	Actual	Variación	Lectura
Operaciones acumuladas (centros)	327 (2024)	373 (2025); 398 (jun-26)	+46 en 2025	245 en 2021 [1, 3].
Ocupación (camas operativas, total)	80,5 %	82,2 %	+1,7 puntos	82,9 % en el 2T26; 84,1 % en los centros iguales [1, 3].
Mezcla de pacientes de alta complejidad (% de ingresos de enfermería)	48,6 %	49,4 %	+0,8 puntos	50,0 % en el 2T26 [1, 3].
Tarifa diaria media de Medicare (USD)	767,72	800,94	+4,3 %	822,24 en el 2T26 [1, 3].
Tarifa diaria media de Medicaid (USD)	294,78	308,27	+4,6 %	313,78 en el 2T26 [1, 3].
Inmuebles propios	158 (dic-25)	183 (jun-26)	+25	144 explotados por filiales de Ensign [3].

3. Sector y mercado

Confianza: Media

Mercado de residencias de cuidados especializados y de larga estancia en EE. UU.: gasto nacional en «nursing care facilities and continuing care retirement communities» de las cuentas sanitarias de CMS, que incluye todos los pagadores [11]. Es más amplio que lo que Ensign vende (incluye comunidades de jubilación), pero es la única serie oficial y homogénea; la proyección del actuario de CMS (Skilled Nursing News) se usa para los años futuros, con la advertencia de que partía de una cifra de 2024 más alta (228.800 M) que la definitiva (219.900 M) [11, 12].

Tamaño del mercado	**219.900 M USD en 2024 (+7,3 %) [11]**	Posición en el ciclo	**Expansión**
Crecimiento histórico anual	**6,8 %**	Crecimiento previsto anual	**6,0 %**
		Estructura	**Fragmentada**



Motores de la demanda

Motor	Efecto	Horizonte	Evidencia
Envejecimiento (mayores de 80 años)	+	Estructural	El actuario de CMS proyecta un crecimiento del gasto del 6,2 % anual en 2026-2027 y del 5,6 % en 2028-2033 [12].
Tarifas de Medicare	+	Cíclico	+3,2 % en el año fiscal 2026 y +2,4 % en 2027 (cesta de mercado 3,3 % − productividad 0,9) [2, 13].
Financiación de Medicaid por los estados (OBBB)	−	Estructural	Congela nuevos impuestos a proveedores (las residencias quedan exentas), limita los pagos dirigidos un 10 % al año desde 2028 y obliga a revisar la elegibilidad cada seis meses desde 2027 [2].
Coste y disponibilidad de personal de enfermería	−	Cíclico	El personal es ~60 % de los gastos de Ensign; muchos estados tienen ratios mínimos propios [1].
Desplazamiento hacia cuidados en casa y Medicare Advantage	+/−	Estructural	Los seguros privados pagan menos por día que Medicare tradicional (609 frente a 822 USD en Ensign) y acortan estancias [3].
Oferta: cierres de centros y poca construcción	+	Estructural	El número de residencias ha bajado ligeramente en los últimos años, según la empresa [1].

Las cinco fuerzas

Amenaza de entrada Poder de los proveedores

Fuerza	Intensidad (1-5)	Justificación
Rivalidad	3	Miles de operadores locales y regionales; se compite por derivaciones de hospitales y por calidad (estrellas de CMS) más que por precio, porque la tarifa la fija el pagador [1].
Poder de los clientes	5	Medicare, Medicaid y Medicare Advantage pagan el 87 % de los ingresos y fijan las tarifas [3].
Poder de los proveedores	4	Personal de enfermería escaso y caro (~60 % de los gastos) y propietarios REIT con contratos de alquiler a largo plazo con subidas anuales [1].
Amenaza de entrada	2	Licencias estatales y certificados de necesidad en muchos estados limitan las camas nuevas; entrar es comprar centros existentes [1].
Amenaza de sustitutos	3	Cuidados en casa, hospitales de rehabilitación y vida asistida para los menos dependientes; la OBBB facilita a los estados financiar cuidados en casa [2].

Ciclo

La ocupación de Ensign sigue subiendo (80,5 % en 2024, 82,2 % en 2025, 82,9 % en el 2T26) tras el hundimiento de la COVID, y el gasto nacional creció un 8,7 % en 2023 y un 7,3 % en 2024 [1, 3, 11]. El sector es poco cíclico frente a la economía (2008-09 apenas le afectó), pero sí frente a la política: en 2020 la COVID vació residencias y solo las ayudas federales sostuvieron márgenes; en 2022-2023 la falta de personal disparó los costes de agencias. El riesgo del ciclo hoy es fiscal: los recortes federales a Medicaid desde 2027-2028 [2].

Regulación

Medicare paga por el sistema PDPM con una subida del 2,4 % desde el 1-oct-2026; CMS pidió información sobre el aumento de la complejidad declarada («case-mix creep»), que podría traer recortes en la regla de 2028 [13]. La norma federal de plantilla mínima de 2024 (3,48 horas por residente y día y enfermera titulada 24/7) quedó suspendida hasta 2034 por la OBBB y CMS la derogó el 2-dic-2025; sigue vigente la enfermera 8 horas diarias y las ratios de cada estado [2, 14]. La OBBB (4-jul-2025) recorta la financiación de Medicaid de forma gradual desde 2027-2028 [2].

Tendencias y disrupción

Tres tendencias. Medicare Advantage gana peso y paga menos por día (en Ensign el 18,5 % de los ingresos) [3]. Los datos públicos de plantilla y calidad de CMS (Care Compare, Payroll Based Journal) son cada vez más usados por reguladores, demandantes y vendedores en corto, como se vio en junio de 2026 [16, 17]. Y la consolidación: operadores en quiebra o vendedores (Genesis) y REIT que buscan inquilinos nuevos dan a Ensign un flujo de compras que la empresa describe como el mejor de su historia [3]. La IA y la automatización afectan sobre todo al papeleo (documentación clínica, facturación) y no al cuidado directo.

4. Posición competitiva y foso

Confianza: Media

Cuota de mercado	**2,3 %**	Posición	**Primer operador cotizado de residencias de EE. UU. por centros (398) y segundo por ingresos tras PACS Group (5.551 M frente a 5.487 M en los últimos 12 meses); ≈ 2,3 % del gasto nacional en residencias de 2024 (5.058 M de 219.900 M, estimación propia) [11, 15].**
Foso	**Estrecho**	Tendencia del foso	**Estable**

Competidor	País	Cotiza	Ingresos (M)	Cuota	Cómo compite
PACS Group	EE. UU.	PACS	5.551	2,5 %	Mismo modelo de compra y mejora, más joven y más endeudado; margen EBITDA LTM del 8,6 % (Yahoo) [15].
Genesis HealthCare	EE. UU.	–	–	–	Antiguo líder; no cotiza y entró en concurso de acreedores en 2025 (Skilled Nursing News).
National HealthCare	EE. UU.	NHC	1.559	0,7 %	Operador del sureste, propietario de sus inmuebles; margen EBITDA LTM del 12,2 % (Yahoo) [15].
Brookdale Senior Living	EE. UU.	BKD	2.932	–	Vida asistida (no enfermería especializada); pérdidas en 2022-2025 y deuda alta [15].
Encompass Health	EE. UU.	EHC	6.206	–	Hospitales de rehabilitación: compite por el mismo paciente que sale del hospital; margen EBITDA del 23,6 % con inmuebles propios [15].
The Pennant Group	EE. UU.	PNTG	1.102	–	Escindida de Ensign en 2019: cuidados en casa, hospicio y vida asistida [15].



Fuentes de ventaja competitiva



Fuente	Puntuación (0-5)	Evidencia
Efectos de red	1	Los «clusters» locales comparten prácticas y derivaciones de hospitales, pero no hay efecto de red propiamente dicho [1].
Costes de cambio	1	El paciente o el hospital eligen centro en cada ingreso.
Intangibles (marca, patentes, licencias)	2	Licencias estatales y certificados de necesidad protegen las camas existentes; la reputación clínica (calificaciones de CMS un 23 % mejores que la media de sus estados, más del 80 % con 4 o 5 estrellas en calidad) atrae derivaciones [8].
Ventaja en costes	3	Modelo descentralizado y escala en compras, sistemas y seguros; el EBIT del segmento de enfermería es el 12,7 % de sus ventas en 2025 frente a un margen EBITDA del 8,6 % de PACS [1, 7].
Escala eficiente	2	Mercados locales con oferta limitada, pero sin barreras para que otro operador compre al lado.

Amenazas

La principal amenaza no es un competidor sino el pagador: si los estados recortan Medicaid (el 39,6 % de los ingresos más el 5,6 % de Medicaid de cuidados especializados) o si CMS corrige el «case-mix creep» del PDPM, el margen baja para todo el sector [2, 3, 13]. La segunda es reputacional y regulatoria: las acusaciones de Hunterbrook (plantilla un 26,8 % por debajo de lo recomendado por CMS en 2024) y de Muddy Waters (licencias de administradores «alquiladas» en el ~20 % de los centros visitados) atacan justo la ventaja de calidad [16, 17]. La tercera, el precio de las compras: con más compradores (PACS, fondos) los centros con potencial de mejora se encarecen.

Parte II — Finanzas

5. Cuenta de resultados

Confianza: Alta

Periodo	Ingresos	Crec.	M. bruto	EBITDA	M. EBITDA	EBIT	M. EBIT	B. neto	BPA	DPA	Tipo imp.
2020	2.403	–	17,0 %	278	11,6 %	223	9,3 %	171	3,06	0,20	21 %
2021	2.628	+9,4 %	17,8 %	317	12,0 %	261	9,9 %	195	3,42	0,21	23 %
2022	3.026	+15,1 %	17,1 %	359	11,9 %	297	9,8 %	225	3,95	0,22	22 %
2023	3.729	+23,3 %	15,8 %	389	10,4 %	316	8,5 %	209	3,65	0,23	23 %
2024	4.261	+14,2 %	15,7 %	442	10,4 %	358	8,4 %	298	5,12	0,24	23 %
2025	5.058	+18,7 %	15,8 %	530	10,5 %	425	8,4 %	344	5,84	0,25	25 %

Crecimiento anual compuesto 2020-2025: ingresos **16,1 %**, EBITDA **13,8 %**, BPA **13,8 %**.



Los ingresos pasaron de 2.402,6 M USD en 2020 a 5.057,8 M en 2025 (TCAC del 16 %, según la propia empresa) y a 5.486,7 M en los doce meses a junio de 2026 [1, 3]. Más o menos la mitad del crecimiento es comprado: en 2025 los centros adquiridos desde 2024 sumaron 489,2 M de los 797,4 M de aumento, y el resto vino de ocupación (+2,1 puntos, al 82,2 %), más pacientes de alta complejidad («skilled mix» del 49,4 % de los ingresos de enfermería) y tarifas [1]. En el 2T26 los centros «iguales» (comprados antes de 2023) crecieron un 6,6 % y el total un 17,3 % [3]. El margen EBITDA (EBIT + amortizaciones) fue del 11,6 % en 2020, 12,0 % en 2021 y 11,9 % en 2022; cayó al 8,8 % en 2023 por el litigio de 60,8 M (10,4 % sin él) y se ha recuperado al 10,5 % en 2025 y al 10,9 % en el 1S26 [1, 3, 7]. Los centros recién comprados tienen menos ocupación (76,6 % en el 2T26) y diluyen el margen hasta que maduran [3].

Ajustes y partidas no recurrentes

Cifras GAAP. La empresa publica un BPA «ajustado» que excluye la remuneración en acciones (48,3 M en 2025, 30,1 M en el 1S26), los costes de implantación de sistemas, los costes de compras, la amortización de la «base de pacientes» comprada y los litigios fuera del curso normal [3, 5]. La diferencia es grande y recurrente: 6,57 USD ajustado frente a 5,84 GAAP en 2025 y 3,77 frente a 3,35 en el 1S26 [3, 5]. Como la remuneración en acciones es un coste real que se repite, el informe trabaja en GAAP; solo se trata como no recurrente el litigio de directores médicos de 2023 (60,8 M dentro del EBITDA; acuerdo de 48 M en enero de 2024) [7]. En 2020-2023 los ingresos incluyen ayudas estatales ligadas a la COVID (75,2 M en 2021, 81,8 M en 2022, 64,8 M en 2023) [7].

6. Resultados recientes

Confianza: Alta

Periodo	Ingresos	Crec. interanual	EBITDA	M. EBITDA	BPA	Frente al consenso
3T24	1.082	–	114	10,6 %	1,34	–
4T24	1.132	–	123	10,8 %	1,36	–
1T25	1.173	+16,1 %	126	10,7 %	1,37	–
2T25	1.228	+18,5 %	135	11,0 %	1,44	–
3T25	1.296	+19,8 %	129	9,9 %	1,42	–
4T25	1.361	+20,2 %	154	11,3 %	1,61	–
1T26	1.389	+18,4 %	153	11,0 %	1,67	–
2T26	1.441	+17,3 %	162	11,3 %	1,68	Superior



Lo que dijo la dirección en las últimas presentaciones

En el 2T26 (27-jul-2026) la dirección subió por tercera vez la guía de 2026: BPA ajustado de 7,75-7,85 USD (antes 7,48-7,62; la inicial de febrero era 7,41-7,61) e ingresos de 5.870-5.920 M [3, 4, 5]. El BPA ajustado de 1,92 USD batió en 0,07 la previsión media y los ingresos quedaron en línea (titulares de Seeking Alpha). El mensaje cambió respecto al 1T: además de ocupación (84,1 % en los centros iguales, +2,7 %) y mezcla de pacientes, el consejero delegado dedicó el comunicado a la calidad clínica (calificaciones de CMS un 23 % mejores que la media de sus estados, ningún centro en la lista de «Special Focus Facilities», rotación de directores un 46 % menor) y a la plantilla, en clara respuesta a los informes bajistas de junio, sin nombrarlos [3]. El responsable de inversiones advirtió que los 20 centros comprados en Texas tienen ocupación baja y «retos clínicos y operativos importantes» [3]. La empresa no ha respondido públicamente punto por punto a Hunterbrook y Muddy Waters; a UBS le dijo que los datos de plantilla del «Payroll Based Journal» de CMS están incompletos y que solo 6 de sus 396 centros tenían el administrador en transición (Orange County Business Journal).

7. Balance y capital circulante

Periodo	Activo total	Fondo com. + intang.	Circulante	Caja	Deuda fin.	Arrend.	Deuda neta	Patrimonio	DN/ EBITDA
2020	2.546	57	254	237	116	0	-121	818	-0,4x
2021	2.851	63	271	262	157	0	-106	1.021	-0,3x
2022	3.452	83	331	316	153	0	-163	1.247	-0,5x
2023	4.178	83	392	510	149	0	-360	1.492	-0,9x
2024	4.669	105	471	465	146	0	-319	1.837	-0,7x
2025	5.463	104	540	504	142	0	-362	2.232	-0,7x

Periodo	Circulante / ventas	Días de cobro	Días de inventario	Días de pago	Ciclo de caja (días)	Liquidez corriente
2020	10,6 %	46	0	9	37	1,0x
2021	10,3 %	46	0	10	36	1,2x
2022	11,0 %	49	0	11	38	1,3x
2023	10,5 %	47	0	11	36	1,4x
2024	11,1 %	49	0	10	39	1,6x
2025	10,7 %	46	0	8	38	1,4x

Días de inventario y de pago calculados sobre el coste de ventas.

El balance es de caja neta si no se cuentan los arrendamientos: 262,3 M de caja frente a 139,7 M de deuda hipotecaria a junio de 2026 [2]. La caja bajó desde 503,9 M en diciembre porque las compras del semestre (376,0 M, casi todo inmuebles de 20 centros en Texas) y las recompras (40 M) superaron al flujo operativo (272,1 M) [2]. El circulante comercial (clientes − proveedores) ronda el 10,5 % de las ventas y los días de cobro han estado estables en ~45 días [1]. El apalancamiento real está en los alquileres: 2.110,6 M de pasivo por arrendamiento, unas 3,6 veces el EBITDA, con contratos de muy largo plazo con REIT (CareTrust, Omega, Sabra) y con Pennant [1, 2].

8. Flujos de caja

Confianza: Alta

Periodo	Flujo operativo	Capex	Arrend.	FCF	B. neto	FCF / B. neto	Capex / ventas	Capex / amort.	FCF por acción
2020	373	50	0	323	171	190 %	2,1 %	0,9x	5,79
2021	276	70	0	206	195	106 %	2,6 %	1,2x	3,62
2022	273	88	0	185	225	82 %	2,9 %	1,4x	3,25
2023	377	106	0	271	209	129 %	2,8 %	1,5x	4,72
2024	347	158	0	189	298	63 %	3,7 %	1,9x	3,25
2025	564	194	0	371	344	108 %	3,8 %	1,9x	6,29



Acumulado 2020-2025: FCF **1.544**, conversión **107 %** del beneficio neto; adquisiciones 779, dividendos 76, recompras 85.

El flujo operativo fue de 564,3 M en 2025 (347,2 en 2024 y 376,7 en 2023), una conversión de 1,6 veces el beneficio neto, ayudada por la remuneración en acciones (48,3 M) y por el aumento de salarios y provisiones de autoseguro devengadas (82,8 y 35,3 M) [1]. La inversión en inmovilizado (193,6 M en 2025, el 3,8 % de las ventas) mezcla mantenimiento y reformas de centros comprados; la empresa no separa el de mantenimiento (estimación propia: ~1,5-2 % de las ventas, cerca de la amortización). Las compras son la inversión de crecimiento: 323,3 M en 2025 y 376,0 M solo en el 1S26, sobre todo inmuebles que pasan a Standard Bearer [1, 2]. Con compras, el flujo libre de 2025 fue de 47,4 M; sin ellas, 370,7 M [1]. Dividendos pequeños (14,4 M) y recompras de 20 M en 2025 y 40 M en el 1S26 [1, 2].

9. Calidad contable

Confianza: Media

Auditor	**Deloitte & Touche LLP**		
Opinión del último informe	**Favorable**	Ejercicio analizado	**2025**

Indicador	Valor	Lectura
Altman Z	3,63	Zona segura (> 2,99 seguro; < 1,81 riesgo). No aplica a bancos ni aseguradoras, y subestima la solvencia de empresas con grandes anticipos de clientes o prefinanciación pública (contratistas, construcción), que inflan el pasivo.
Piotroski F	6 / 9	Intermedio (4-6).
Beneish M	-2,56	Por debajo de −1,78: sin señal de manipulación.
Flujo operativo / beneficio neto (acumulado)	1,53x	El beneficio se cobra.

Criterio Piotroski	Cumple
Beneficio neto positivo	Sí
Flujo operativo positivo	Sí
ROA mejora	No
Flujo operativo > beneficio neto	Sí
Baja el endeudamiento (deuda / activo)	Sí
Mejora la liquidez corriente	No
No emite acciones	No
Mejora el margen bruto	Sí
Mejora la rotación del activo	Sí

Ajustes, criterios contables y remuneración en acciones

Cuentas en US GAAP con opinión favorable de Deloitte [1]. Tres puntos piden atención. Primero, la remuneración en acciones es alta y creciente (48,3 M en 2025, 1 % de las ventas; 202,6 M pendientes de reconocer a junio de 2026) y la empresa la excluye de su BPA ajustado [2, 5]. Segundo, los ingresos se reconocen por estancias con tarifas pactadas más consideración variable (ajustes de Medicare y Medicaid), y las cuentas a cobrar crecieron con las ventas (637 M, 12,6 % de las ventas) [1]. Tercero, las acusaciones de junio de 2026 (Hunterbrook y Muddy Waters) no son contables, pero tocan la base de los ingresos: si un centro no tiene administrador con licencia, Medicare y Medicaid pueden reclamar lo cobrado; la empresa no ha provisionado nada ni ha anunciado una investigación interna [2]. El Beneish y el Piotroski del motor salen sin alertas en 2024-2025; el Altman Z es alto porque el pasivo por arrendamiento no entra como deuda.

Señales de alerta

Señal	Nivel	Explicación
Remuneración en acciones excluida del BPA ajustado	Media	48,3 M en 2025 (0,73 USD de diferencia entre BPA ajustado y GAAP) [5].
CID del Departamento de Justicia sin resolver (Medicare y Medicaid de Texas desde 2016)	Media	Recibida en enero de 2024; sin provisión ni estimación [2]. En 2024 pagó 48 M por otro caso de la Ley de Reclamaciones Falsas [7].
Acusaciones de vendedores en corto sobre plantilla y licencias de administradores	Alta	Sin acción de ningún regulador cuatro meses después; demanda colectiva de accionistas presentada en octubre [2].

10. Rentabilidad sobre el capital

Confianza: Media

Periodo	ROIC	ROE	ROA	Margen neto	Rotación del activo	Apalancamiento	Capital invertido	ROIC sin f. de comercio
2020	25,2 %	20,8 %	6,7 %	7,1 %	0,94x	3,11x	697	27,4 %
2021	24,7 %	21,2 %	7,2 %	7,4 %	0,97x	2,93x	807	26,6 %
2022	23,0 %	19,8 %	7,1 %	7,4 %	0,96x	2,78x	1.001	24,7 %
2023	21,9 %	15,3 %	5,5 %	5,6 %	0,98x	2,79x	1.111	23,5 %
2024	20,8 %	17,9 %	6,7 %	7,0 %	0,96x	2,66x	1.329	22,3 %
2025	18,9 %	16,9 %	6,8 %	6,8 %	1,00x	2,49x	1.697	20,1 %

Fondo de comercio y compras

Fondo de comercio: 98 M en 2025 (el 6 % del capital invertido medio); ha subido más de un 5 % en 3 de 5 años: comprador en serie. ROIC publicado 18,9 %; sin fondo de comercio, 20,1 %. En un comprador en serie el fondo de comercio es el precio de su crecimiento: juzga el publicado.

ROIC incremental (variación del NOPAT sobre variación del capital invertido en el periodo): 14,5 % · **WACC**: 9,8 %.

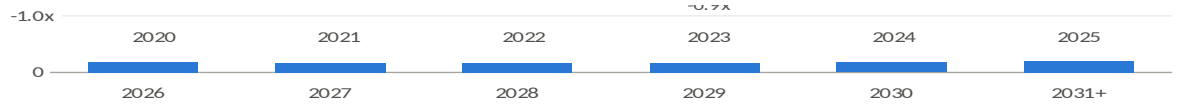
Ensign crea valor desde hace años con el ROIC del motor: 25,2 % en 2020 y 18,9 % en 2025, frente a un WACC del 9,8 % (+9,1 puntos), y un ROIC incremental del 14,5 % en 2020-2025 [1, 10]. Lo mueve la rotación (≈ 1,0 veces el activo) más que el margen (6,8 % neto): el modelo es alquilar o comprar barato residencias con problemas y subir la ocupación y la mezcla de pacientes de Medicare. El ROIC baja año a año (de 25 % a 19 %) porque desde 2024 compra más inmuebles (Standard Bearer) en vez de alquilarlos: 155 M en 2024, 327 M en 2025 y 375 M solo en el 1S26 [1, 2]. Ojo: el capital invertido no incluye los arrendamientos de los centros (≈ 1.990 M de pasivo [2]); tratándolos como deuda, el ROIC baja a ≈ 11 %, solo 1-2 puntos por encima del WACC [2]. PACS, el rival más parecido, tiene márgenes menores (8,6 % de EBITDA frente al 10,6 %) [28].

11. Deuda y solvencia

Confianza: Alta

Deuda neta a 30 jun 2026	**-123 M**	Deuda neta / EBITDA últimos 12 m	**-0,2x**

Deuda neta ajustada / EBITDA	**-0,2x**	Liquidez disponible	**Caja 262,3 M USD a 30-jun-2026 y 591,6 M disponibles en la línea de crédito; la línea se amplió a 800 M con vencimiento en agosto de 2031 (8-K del 20-ago-2026) [2, 3].**
Rating	**Sin rating**	Coste medio de la deuda	**5,6 %**



Covenants, pasivos fuera de la deuda y contingencias

La deuda financiera son préstamos hipotecarios a largo plazo asegurados por HUD sobre inmuebles propios (139,7 M a 30-jun-2026; 124,5 M vencen después de 2030) [1, 2]. Los arrendamientos operativos de 253 centros suman 2.110,6 M de pasivo (121,1 corto + 1.989,5 largo) y 242 M de pagos en 2025; en US GAAP el alquiler ya resta en el EBITDA y no se suman a la deuda [1, 2]. Seguros propios (filial cautiva): provisiones de autoseguro de 295,8 M frente a 268,6 M de inversiones y depósitos de la filial (210,1 + 58,5) [2]. Litigios: acuerdo de 12 M por demandas laborales en California (provisionado), CID del Departamento de Justicia de enero de 2024 sobre facturación a Medicare y Medicaid de Texas desde 2016 (sin provisión ni estimación) y la revisión de la oficina de costes sanitarios de California (OHCA), recurrida en los tribunales [2].

12. Asignación de capital

Confianza: Media

Prioridad declarada: crecer comprando o alquilando residencias con problemas (sobre todo en Arizona, California, Texas y el oeste) y, desde hace dos años, comprar los inmuebles a través de Standard Bearer, su inmobiliaria cautiva (177 inmuebles a junio de 2026) [1, 2]. Dividendo pequeño (0,065 USD por trimestre, ≈ 0,15 % de rentabilidad) subido 23 años seguidos [5]. Recompras oportunistas: 20 M en el 1S25 y 40 M en el 2T26 (257.000 acciones a ≈ 156 USD), con una autorización ampliada a 100 M en junio de 2026, tras los informes bajistas [2, 23]. Deuda casi nula (139,7 M de hipotecas frente a 262,3 M de caja) y una línea de crédito renovada en agosto de 2026 [2].

Periodo	FCF	Adquisiciones	Dividendos	Recompras	Ampliaciones	Retorno / B. neto	Acciones (M)
2020	323	25	11	25	13	21 %	55,8
2021	206	104	12	10	9	11 %	56,9
2022	185	101	12	30	13	19 %	56,9
2023	271	69	13	0	18	6 %	57,3
2024	189	157	14	0	22	5 %	58,2
2025	371	323	14	20	29	10 %	58,9



Historial de adquisiciones

Año	Objetivo	Importe	Financiación	Resultado
2021	Centros de enfermería e inmuebles (compras y arrendamientos a largo plazo)	104	Caja propia	Sin deterioros; las operaciones pasan de 228 a 245 [8].
2022	Centros de enfermería e inmuebles	101	Caja propia	Sin deterioros [8].
2023	Centros de enfermería e inmuebles	69	Caja propia	Sin deterioros del fondo de comercio en 2023-2025 [1].
2024	Centros e inmuebles (154,9 M de inmuebles)	157	Caja propia	Ocupación de los centros iguales al alza; sin deterioros [1].
2025	40 residencias de enfermería, 5 de vida asistida y 1 campus en varios estados (4.175 camas); 326,7 M de inmuebles	323	Caja propia	Explica ≈ 9 de los 24 puntos de crecimiento de 2025; sin deterioros [1].
2026 (1S)	21 residencias de enfermería y 2 campus en cuatro estados; 375,3 M de inmuebles	375	Caja propia	Demasiado pronto; maduran en 2-3 años [2].

Es un comprador en serie disciplinado: compra centros pequeños, baratos y con problemas (casi nunca empresas con fondo de comercio: 98 M, el 6 % del capital) y los arregla en 2-3 años, sin deterioros publicados en 2023-2025 y con caja propia [1]. El cambio reciente es de forma de pago: compra más inmuebles en vez de alquilar, lo que sube el capital invertido, baja el ROIC publicado y hace caer el flujo libre después de compras a 47 M en 2025 (419 M antes de compras en el LTM). El crecimiento de los últimos años (≈ 16-24 % de ventas) lleva dentro 5-9 puntos de compras: el orgánico ronda el 7-9 % [1, 3]. Las recompras de junio (≈ 156 USD) fueron una respuesta a los informes bajistas, no una política.

Parte III — Equipo y gobierno

13. Equipo directivo

Confianza: Alta

Nombre	Cargo	Desde	% capital	Trayectoria y resultados
Barry R. Port	Consejero delegado y presidente	2019	0,49 %	En Ensign desde 2006; presidente de Keystone (Texas) y director de operaciones de Ensign Services 2012-2019; consejero delegado desde mayo de 2019 y presidente desde septiembre de 2025. Con él los ingresos se han duplicado y el BPA GAAP ha crecido un 14 % anual entre 2020 y 2025 [3, 21].
Suzanne D. Snapper	Directora financiera y vicepresidenta ejecutiva	2009	0,72 %	En Ensign desde abril de 2007, directora financiera desde agosto de 2009 y consejera desde 2022; llevó las escisiones de CareTrust (2014) y Pennant (2019) y la creación de Standard Bearer (2022) [18].
Chad A. Keetch	Director de inversiones y vicepresidente ejecutivo	–	0,28 %	Responsable de las compras y de Standard Bearer; 102 operaciones nuevas desde 2024 [3, 18].
Spencer W. Burton	Presidente y director de operaciones de Ensign Services	–	0,27 %	Dirige el día a día de los centros desde la escisión de Pennant [18].
Marivic Uychiat Pison	Vicepresidenta ejecutiva de servicios clínicos y consejera	2016	0,04 %	Enfermera, 22 años en la empresa; consejera desde septiembre de 2025 [21].

¿Cumple lo que promete?

Año	Lo que prometió	Lo que logró	Cumplió
2025	BPA ajustado 6,22-6,38 USD (julio de 2025), elevada a 6,34-6,46 y a 6,48-6,54 (noviembre)	6,57 USD	Sí
2026	BPA ajustado 7,41-7,61 USD (febrero), elevada a 7,48-7,62 (abril) y a 7,75-7,85 (julio); ingresos 5.870-5.920 M	3,77 USD en el 1S26 (en curso)	Parcial

Equipo estable y formado dentro de la casa: el consejero delegado lleva en Ensign desde 2006 y la directora financiera desde 2007 [18, 21]. La guía se cumple y se eleva casi cada trimestre (2025 cerró en 6,57 frente a una última guía de 6,48-6,54) [3]. La sucesión del fundador fue ordenada (2019 consejero delegado, 2025 presidencia) [21]. El punto débil es la credibilidad pública tras junio de 2026: la dirección respondió con una recompra y mensajes de calidad, no con una refutación detallada, y la demanda colectiva nombra al consejero delegado y a la directora financiera [23, 25, 26].

14. Gobierno corporativo

Confianza: Alta

Consejeros	**9**	Independientes	**67 %**
Antigüedad media en el consejo	**6,3 años**	Criterios de buen gobierno cumplidos	**10 de 13 (1 sin dato)**
Cambios de presidente o primer ejecutivo (24 meses)	**0**		

Consejero	Cargo	Tipo	Desde	Comisiones
Barry R. Port	Presidente y consejero delegado	Ejecutivo	2019	Calidad y cumplimiento
Suzanne D. Snapper	Consejera, directora financiera	Ejecutivo	2022	Calidad y cumplimiento
Marivic Uychiat Pison	Consejera, vicepresidenta de servicios clínicos	Ejecutivo	2025	Calidad y cumplimiento
Barry M. Smith	Consejero independiente coordinador	Independiente	2014	Retribuciones; Nombramientos (presidente)
Swati B. Abbott	Consejera	Independiente	2020	Auditoría; Retribuciones (presidenta); Nombramientos
Daren J. Shaw	Consejero	Independiente	2012	Auditoría (presidente); Retribuciones
Ann S. Blouin	Consejera	Independiente	2018	Calidad y cumplimiento (presidenta); Nombramientos
John O. Agwunobi	Consejero	Independiente	2023	Auditoría; Calidad y cumplimiento
Mark V. Parkinson	Consejero	Independiente	2024	Calidad y cumplimiento; Nombramientos

Criterio	Dato	Resultado
Consejeros independientes ≥ 50 % (≥ 33 % si hay accionista de control)	67 %	Cumple
Presidencia sin vínculo familiar ni profesional con el accionista de control	Sin control	Cumple
Presidente no ejecutivo, o consejero coordinador independiente	Ejecutivo, con coordinador	Cumple
Comisión de auditoría con mayoría de independientes y presidida por uno	Sí	Cumple
Ningún consejero «otro externo» con más de 12 años	Ninguno	Cumple
Estabilidad de la cúpula: como mucho un cambio de presidente o primer ejecutivo en 24 meses	0 cambios	Cumple
Peor voto en contra sobre remuneración (3 juntas) ≤ 20 %	5,4 % en contra	Cumple
Variable a largo plazo ligado a rentabilidad (ROIC, TSR, FCF)	No	No cumple
Una acción, un voto, sin blindajes ni límites de voto estatutarios	Sí	Cumple
Sin operaciones vinculadas relevantes	No hay	Cumple
Auditor con 10 años o menos en el cargo	Sin dato	Sin dato
Opinión de auditoría sin salvedades	Favorable	Cumple
Directivos compradores netos en 12 meses (o sin ventas relevantes)	Compras 0,00 / ventas 12,59 M	No cumple

Accionariado

Accionista	% capital	Tipo	Movimientos recientes
BlackRock	12,20 %	Institucional	Dato del 13G/A de octubre de 2024 [18].
Baillie Gifford	7,80 %	Institucional	13G de febrero de 2026 [18].
Wasatch Advisors	4,90 %	Institucional	Bajó del 5 % (13G/A de febrero de 2026) [18].
Christopher R. Christensen (cofundador)	2,00 %	Fundador	Fuera del consejo desde septiembre de 2025 [18].
Consejeros y directivos (12 personas)	4,00 %	Directivos	Incluye opciones ejercitables [18].



Compras y ventas de consejeros y directivos (12 meses)

Fecha	Persona	Operación	Acciones	Importe (M)
nov 2025	Barry R. Port (consejero delegado)	Venta	28.315	5,12
nov 2025	Spencer W. Burton (director de operaciones)	Venta	11.798	2,11
dic 2025	Beverly B. Wittekind (directora jurídica)	Venta	10.400	1,83
feb 2026	Suzanne D. Snapper (directora financiera)	Venta	12.831	2,50
nov 2025	Barry M. Smith (consejero; 700 acciones al mes)	Venta	5.600	1,03

Remuneración

Remuneración total del primer ejecutivo (2025)	**13,80 M**	Fijo	**0,55 M**
Variable anual	**10,32 M**	Variable a largo plazo	**2,91 M**
Peor voto a favor (3 juntas)	**94,5 %**	Peor voto en contra (3 juntas)	**5,4 %**
Ratio sobre salario medio	**290x**		

La remuneración de la cúpula es casi toda variable y anual: el consejero delegado cobró 13,8 M USD en 2025, de ellos 0,55 M de fijo, 10,3 M de incentivo anual en efectivo y 2,9 M en acciones [18]. El incentivo sale de un fondo de directivos (41,9 M en 2025) calculado con una fórmula sobre el beneficio antes de impuestos ajustado, que el comité reparte mirando también criterios clínicos (inspecciones, reingresos, rotación de enfermería, estrellas de CMS) y de gobierno; en 2025 se restaron del cálculo la remuneración en acciones y el litigio laboral de 12 M; por encima de 5 M de fondo, el 25 % se paga en acciones con un año de permanencia [18]. No hay métricas de rentabilidad del capital (ROIC) ni de rentabilidad para el accionista a varios años: premia crecer el beneficio, también comprando centros. Ratio con el empleado mediano: 290 a 1 [18]. El voto consultivo de 2026 fue favorable (48,6 M a favor, 2,8 M en contra) [19]. Al fundador que se retiró se le pagó un bono de 2,07 M y se le aceleraron opciones [22].

Operaciones vinculadas, estructura de control y defensas

No hay accionista de control: el mayor es BlackRock (12,2 %) y la familia fundadora tiene ~2 % [18]. Una acción, un voto y mayoría para elegir consejeros, pero el consejo está escalonado en tres clases (cada consejero se elige cada tres años), lo que frena un cambio de control hostil [18]. En agosto de 2026 el consejo reformó los estatutos para endurecer los requisitos de las propuestas y candidaturas de accionistas (plazo de 90-120 días) [24]. Hay familiares de directivos en puestos de la empresa (hermano del fundador, cuñados del director de operaciones y del de inversiones), declarados como partes vinculadas de importe menor [18].

Señales de alerta

- Demanda colectiva de accionistas Perusek v. The Ensign Group (C.D. Cal., 8:26-cv-02963), periodo 10-feb-2022 a 18-jun-2026, contra la empresa, el consejero delegado y la directora financiera; plazo para el demandante principal: 7-dic-2026 [25].
- CID del Departamento de Justicia (enero de 2024) sobre facturación a Medicare y Medicaid de Texas desde 2016, sin resolver [2].
- Informes de Hunterbrook y Muddy Waters (junio de 2026) sobre plantilla y licencias de administradores; la empresa negó en privado (a UBS) y no ha publicado una refutación [26].
- Presidente y consejero delegado en la misma persona desde septiembre de 2025, con consejo escalonado [18, 21].

Parte IV — Mercado y valoración

15. Previsiones de la compañía y consenso

Confianza: Media

Guía de 2026 (27-jul-2026): BPA ajustado de 7,75-7,85 USD (+18,7 % en el punto medio) e ingresos de 5.870-5.920 M, con 59,5 M de acciones diluidas y un 25 % de impuesto; excluye remuneración en acciones, costes de sistemas y de compras, e incluye solo las compras que cierren hasta el 3T [3]. Es la tercera subida del año (inicial: 7,41-7,61). No hay plan a medio plazo publicado.

Periodo	Ingresos	BPA	DPA	Fuente
2026e	5.905	7,81	0,26	Yahoo Finance, 5 analistas (BPA ajustado) [28]
2027e	6.566	8,59	0,27	Yahoo Finance, 5 analistas (BPA ajustado) [28]

Nuestra proyección frente al consenso

Periodo	Ingresos propios	Ingresos consenso	Dif.	EBITDA propio
2026e	5.897	5.905	-0,1 %	643
2027e	6.558	6.566	-0,1 %	721

Analistas	**5**	Comprar / mantener / vender	**4 / 1 / 0**
Precio objetivo medio	**220,00**	Rango de precios objetivo	**207,00 – 230,00**

Revisiones de estimaciones

Las estimaciones suben: el BPA de 2026 pasó de 7,56 USD hace 90 días a 7,81 y el de 2027 de 8,33 a 8,59, tras la subida de guía del 2T [28]. En 3 meses los objetivos se mantienen en 207-230 USD (RBC de 222 a 228 en julio; Oppenheimer 210 en septiembre; Truist mantener en octubre) [29]. Son estimaciones ajustadas (sin remuneración en acciones): la diferencia con el GAAP ronda los 0,85-0,90 USD por acción en 2026. Solo hay una fuente con estimaciones completas (Yahoo); Stock Analysis confirma el objetivo medio (220 USD) y el BPA de 2026 (7,81) [28, 29].

16. Comportamiento en bolsa

Confianza: Alta

Rentabilidad total (con dividendos).

Periodo	Acción	Índice	Sector
En el año	-0,6 %	+13,3 %	+14,9 %
1 año	-4,8 %	+16,6 %	+24,6 %
3 años (anual.)	+21,7 %	+23,1 %	+12,8 %
5 años (anual.)	+18,8 %	+12,7 %	+8,2 %
10 años (anual.)	+25,5 %	+15,4 %	+11,5 %



Beta (5 años, mensual)	**0,66**	Volatilidad anualizada (1 año)	**27,7 %**
Máxima caída (5 años)	**-31,8 %**	Posiciones cortas	**3,0 %**

Ensign ha sido una de las mejores acciones del sector sanitario a largo plazo: +25,5 % anual en 10 años y +18,8 % en 5, frente a +15,4 % y +12,7 % del S&P 500 [27]. En los últimos 12 meses va un −4,8 % frente al +16,6 % del índice: marcó máximos en 218 USD el 2-mar-2026, cayó hasta 141,58 el 11-jun tras los informes de Hunterbrook y Muddy Waters (−31,8 % desde máximos) y recuperó un 15 % tras los resultados del 2T26 [16, 17, 27]. La beta es baja (0,66 mensual a 5 años; 0,11 semanal a 2 años) y la volatilidad del 27,7 % [27].

Precio y noticias antes de decidir (regla 13)

Variación 1 / 3 / 6 / 12 meses	**-0,5 % / +1,3 % / -12,4 % / -3,6 %**	Frente al máximo y al mínimo de 52 semanas	**-19,8 % / +17,6 %**
Frente al máximo de 5 años	**-19,8 %**	Tendencia (medias de 50 y 200 sesiones)	**bajista**
Volatilidad (60 sesiones)	**20,0 %**	Próximos resultados	**2026-11-02**
Veredicto	**no cambia**		

Periodo	Variación	Causa	Veredicto
oct-2025	+10,8 %	Subida de 21 sesiones hasta el 22-oct-2025 (184,79 USD), antes de los resultados del 3T25 (3-nov, guía elevada); no hay un hecho propio que la explique en el día [6, 27].	no cambia
feb-2026	+26,9 %	Resultados de 2025 y guía de 2026 (4-feb): +13,8 % el 5-feb y máximo histórico de 218 USD el 2-mar [5, 27].	no cambia
may-2026	-14,9 %	Caída gradual del 2-mar al 11-may (de 216 a 169 USD), sin ningún día de −5 %; los resultados del 1T (30-abr) subieron la guía. Sin hecho propio identificado: corrección del múltiplo tras la subida de febrero [4, 27].	no cambia
jun-2026	-16,4 %	Informes bajistas: Hunterbrook (8-jun, plantilla insuficiente y pagos a filiales; −8,2 % en el día) y Muddy Waters (11-jun, licencias de administradores «alquiladas»; −3,0 %); mínimo de 141,58 USD [16, 17, 27]. La empresa amplió la recompra a 100 M y compró 40 M en el trimestre [23].	no cambia
jul-2026	+15,0 %	Resultados del 2T26 (27-jul): ocupación y tarifas al alza y tercera subida de la guía de 2026 (BPA ajustado 7,75-7,85 USD) [3, 27].	no cambia

Fecha	Tipo	Hecho	Veredicto	Condición
2026-06-08	rumor	Hunterbrook publica que muchos centros de Ensign tienen menos plantilla de la que declaran y que pagó 339 M USD a filiales; posición corta declarada [16].	no cambia	Si un regulador (CMS, DOJ, un estado) abre un expediente nuevo sobre esos hechos, se rehace el informe.
2026-06-11	rumor	Muddy Waters, corto: licencias de administradores «alquiladas» en 12 de 57 centros revisados; habla de sanciones teóricas de 7.000 M USD y de un EBIT de 2027 un 35 % menor [17]. La empresa dice a UBS que solo 6 de 396 centros tenían el administrador en transición; ningún regulador ha actuado [26].	no cambia	–
2026-06-15	ampliación o convertible	Recompra ampliada a 100 M USD; 257.000 acciones compradas por 40 M en el 2T26 (≈ 156 USD) [2, 23].	no cambia	–
2026-10-08	demanda o regulador	Demanda colectiva Perusek v. The Ensign Group (C.D. Cal.) por las caídas de junio; plazo para el demandante principal el 7-dic-2026. Es la consecuencia habitual de los informes bajistas; sin fecha de decisión que mueva el precio [25].	no cambia	–
2024-01	demanda o regulador	Requerimiento civil (CID) del Departamento de Justicia sobre la facturación a Medicare y Medicaid de centros de Texas desde 2016, sin resolver y sin fecha [2].	no cambia	Si el DOJ presenta demanda o pide una cifra, se recalcula.
2025-10/2026-10	directivos	Ventas de directivos por 13,6 M USD en 12 meses, todas con planes 10b5-1 (Port 5,1 M); ninguna compra [20].	no cambia	–
2026-07/2026-10	recomendación	5 analistas, 4 comprar y 1 mantener; objetivos de 207-230 USD sin recortes en 3 meses (RBC sube a 228 en julio) [28, 29].	no cambia	–
2026-11-02	resultados	Resultados del 3T26 previstos hacia el 2-nov (fecha estimada, sin confirmar por la empresa) [28].	no cambia	–

La acción está un 20 % por debajo del máximo de marzo y en tendencia bajista suave (−4,7 % bajo la media de 200). La caída de junio tiene una causa conocida, los informes de Hunterbrook y Muddy Waters, que este análisis recoge en riesgos y en el escenario bajista; los resultados del 2T26 la recuperaron en parte. No hay un hecho pendiente con fecha (colocación, ampliación, decisión regulatoria o judicial) que pueda mover el precio más de un 5 %: la demanda colectiva solo tiene plazos procesales y el CID del DOJ no tiene fecha. Los directivos venden con planes programados, sin compras. Veredicto: no cambia (y la acción no es compra por valoración, no por este bloque).

17. Múltiplos frente a su historia

Confianza: Alta

Múltiplo	Actual	Mediana	Mínimo	Máximo	Percentil	Prima / descuento
EV/EBITDA últimos 12 meses (cierre de cada año)	17,5x	15,2x	14,2x	18,7x	83 %	+15 %
PER últimos 12 meses (cierre de cada año)	27,1x	25,2x	23,8x	30,7x	67 %	+8 %

PER GAAP de los últimos doce meses al cierre de cada año: 23,8 veces en 2020, 24,5 en 2021, 24,0 en 2022, 30,7 en 2023 (beneficio hundido por el litigio), 25,9 en 2024 y 29,8 en 2025 [27]. Hoy, 27,1 veces el BPA GAAP de los últimos 12 meses (6,38 USD) y 20,2 el ajustado del consenso de 2027 [28]. La caída desde marzo devolvió el múltiplo a la parte baja de su rango de cinco años: el mercado descuenta el riesgo regulatorio y legal de junio, no un peor negocio.

18. Comparables cotizados

Confianza: Media

Operadores cotizados de EE. UU. de cuidados posagudos y de larga estancia que cobran de Medicare, Medicaid y seguros: PACS (el más parecido), National HealthCare, Encompass (rehabilitación hospitalaria), Pennant (cuidados en casa y vida asistida, escindida de Ensign), Addus (cuidados personales pagados por Medicaid) y Option Care (infusión en casa). Fuera: las REIT (CareTrust, Omega, Sabra), porque su BPA y su margen son de propietario; Brookdale, con pérdidas; y Select Medical, sin datos completos en la fuente.

Empresa	País	Capitaliz.	EV/Vtas	EV/ EBITDA LTM	PER NTM	Crec.	M. EBITDA	ROIC	DN/ EBITDA	FCF yield
Ensign	US	10.296	1,9x	17,5x	20,5x	+13,0 %	10,6 %	18,9 %	-0,2x	4,1 %
PACS Group	US	7.260	–	–	17,0x	+15,4 %	8,6 %	–	–	5,2 %
Encompass Health	US	12.007	–	–	18,5x	+11,0 %	23,6 %	–	–	1,9 %
The Pennant Group	US	1.420	–	–	26,2x	+14,1 %	6,8 %	–	–	0,2 %
Addus HomeCare	US	2.151	–	–	15,5x	+7,2 %	10,9 %	–	–	5,4 %
Option Care Health	US	4.675	–	–	15,3x	+6,3 %	7,1 %	–	–	5,5 %
National HealthCare	US	3.747	–	–	–	–	12,2 %	–	–	1,7 %

La primera fila es la empresa analizada (calculada con sus propios datos). Los estadísticos excluyen a la empresa.

Estadístico	PER NTM	Crec.	M. EBITDA
Mediana	17,0x	+11,0 %	9,8 %
Media	18,5x	+10,8 %	11,5 %
Percentil 25	15,5x	+7,2 %	7,5 %
Percentil 75	18,5x	+14,1 %	11,9 %

Valor implícito por acción

Múltiplo aplicado	Métrica de la empresa	Múltiplo p25 / mediana / p75	Valor p25	Valor mediana	Valor p75	Potencial
PER próximos 12 meses	8,4	15,5x / 17,0x / 18,5x	130,76	143,42	156,07	-17,1 %

Ensign cotiza a 20.5 veces el BPA ajustado de los próximos 12 meses, por encima de la mediana de sus comparables (17) y por debajo solo de Pennant (26,2) [28]. La prima se apoya en el crecimiento (ventas NTM +17.3 % frente a +7-15 % del grupo) y en su historial de 20 años; PACS, con un crecimiento parecido, cotiza a 17 veces, con más deuda y menos historia [28]. Los múltiplos EV/EBITDA no se usan: el EBITDA de los operadores ya resta el alquiler y el valor empresa de la fuente suma los arrendamientos operativos, con perímetros muy distintos (Encompass es propietaria, PACS alquila casi todo). Usaría el PER.

20. Descuento de flujos de caja (DCF)

Confianza: Media

Supuestos y su justificación

Crecimiento de ingresos.

El 2026e es la guía (5.870-5.920 M, punto medio +16,6 %) con dos trimestres publicados [3]; el 2027e es el consenso de ventas (+11,2 %) [28]: unos 6 puntos orgánicos (ocupación del 82-84 %, mezcla de Medicare y tarifas: Medicare +2,4 % en FY27 [13]) y unos 5 de compras. Después las compras se van apagando y el orgánico converge al 4 % en 2033e. Las compras recientes inflan el crecimiento: el orgánico de los centros iguales ronda el 7-9 % [3].

Márgenes.

Margen EBITDA (después del alquiler y de la remuneración en acciones) del 10,5 % en 2025 y del 10,9 % en el 1S26; sube despacio al 11,2 % al madurar los centros comprados y se queda ahí, por debajo del 11,6-12,0 % de 2020-2022 (años con ayudas COVID) [1, 3]. El personal es ≈ 60 % de los gastos: cada punto de salarios por encima de las tarifas resta ≈ 0,6 puntos de margen [1, 2].

Inversión y circulante.

Capex = inmovilizado (≈ 3,4 % de las ventas) + compras de centros e inmuebles: 12,3 % en 2026e (525 M de compras previstas, 376 M ya gastados en el 1S [2]) bajando al 3,9 % en 2033e. Circulante del 10,5 % de las ventas (cobros a Medicare y Medicaid).

Coste del capital.

Tasa libre 5,15 % (Tesoro a 10 años, 19-oct-2026 [30]), beta ajustada 0,77 (mensual a 5 años, 0,66 sin ajustar [27]), prima de mercado 5,5 % y 0,5 puntos más por el riesgo regulatorio y legal concreto (CID del DOJ, informes bajistas, demanda colectiva). Coste de la deuda 5,6 %, peso del 2 %. WACC 9,77 %. Con la prima implícita del mercado (4,2 % [31]) el valor sube a 96,89 USD.

Valor terminal.

Gordon al 3 %: la demanda crece con el envejecimiento (los mayores de 85 años crecen ≈ 4 % al año) pero las tarifas dependen de presupuestos públicos. El valor terminal es el 73 % del total.

Coste medio ponderado del capital

Componente	Valor
Tasa libre de riesgo	5,15 %
Beta	0,77
Prima de riesgo de mercado	5,50 %
Prima adicional (país, tamaño, específica)	0,50 %
Coste de los fondos propios	9,89 %
Coste de la deuda antes de impuestos	5,60 %
Tipo impositivo	25,00 %
Coste de la deuda después de impuestos	4,20 %
Peso de la deuda (D / (D + E))	2,00 %
WACC	9,77 %
Prima de riesgo implícita del mercado (regla relativa)	4,20 %
WACC con la prima implícita del mercado	8,79 %

Proyección

Año	Ingresos	Crec.	EBITDA	M. EBITDA	Amort.	Impuestos	Capex	Δ Circ.	FCFF	Fracción	VA
2026e	5.897	16,6 %	643	10,9 %	127	129	725	80	-291	0,20	-57
2027e	6.558	11,2 %	721	11,0 %	144	144	400	69	108	1,00	101
2028e	7.181	9,5 %	797	11,1 %	158	160	402	65	170	1,00	145
2029e	7.755	8,0 %	869	11,2 %	171	174	396	60	238	1,00	185
2030e	8.298	7,0 %	929	11,2 %	183	187	398	57	287	1,00	203
2031e	8.796	6,0 %	985	11,2 %	194	198	396	52	339	1,00	219
2032e	9.236	5,0 %	1.034	11,2 %	203	208	388	46	393	1,00	231
2033e	9.605	4,0 %	1.076	11,2 %	211	216	375	39	446	1,00	239

FCFF = EBIT × (1 − t) + amortizaciones − capex − variación del circulante. «Fracción» es la parte del ejercicio que queda por delante desde la fecha de valoración; VA, el valor actual.



Valor terminal

Concepto	Valor
Método principal	Crecimiento a perpetuidad
Crecimiento a perpetuidad	3,0 %
Múltiplo EV/EBITDA de salida	14,0x
Valor terminal (Gordon)	6.789
Valor terminal (múltiplo)	15.061
Múltiplo de salida implícito en Gordon	6,3x
Crecimiento implícito en el múltiplo	6,61 %
Peso del valor terminal en el valor empresa	73 %

Del valor empresa al valor por acción

Concepto	Importe
Valor actual de los flujos proyectados	1.266
Valor actual del valor terminal	3.470
Valor empresa	4.736
− Deuda financiera neta (con arrendamientos)	123
− Minoritarios, pensiones y otros; + asociadas	-3
Valor de los fondos propios	4.855
Acciones diluidas (millones)	59,5
Valor por acción	81,60

Sensibilidad: WACC × Crecimiento a perpetuidad

WACC	2,0 %	2,5 %	3,0 %	3,5 %	4,0 %
8,8 %	85,84	91,08	97,23	104,56	113,41
9,3 %	79,29	83,69	88,78	94,77	101,88
9,8 %	73,61	77,33	81,60	86,56	92,37
10,3 %	68,63	71,81	75,43	79,59	84,40
10,8 %	64,23	66,97	70,07	73,59	77,63

Sensibilidad: margen EBITDA × crecimiento de ingresos (desplazamiento de toda la proyección)

Margen \ crec.	-2 pp	-1 pp	0 pp	+1 pp	+2 pp
-2 pp	50,00	51,29	52,59	53,88	55,17
-1 pp	62,99	65,02	67,10	69,21	71,35
0 pp	75,99	78,76	81,60	84,53	87,54
+1 pp	88,98	92,49	96,11	99,86	103,73
+2 pp	101,97	106,22	110,62	115,19	119,92

¿Puede la empresa sostener el crecimiento previsto?

Veredicto: Sí.

Prueba	Valor
Crecimiento medio de ingresos proyectado	8,4 %
Capex bruto medio (incluidas compras si van como inversión)	5,8 % de las ventas
Reinversión neta acumulada (capex − amortización + circulante)	2.557 M (60 % del NOPAT)
Crecimiento que financia esa reinversión al ROIC actual	11,4 % (ROIC 18,9 %)
Crecimiento histórico de ingresos (TCAC)	16,1 % frente al 8,4 % proyectado
Veredicto de las pruebas del motor	Sí
Rendimiento que la proyección supone para el capital nuevo	12,8 % (histórico: 14,5 %)
Cuota de mercado implícita en 2030e	2,6 % (hoy: 2,3 %)

La proyección reinvierte el 60 % del NOPAT. Con el ROIC del último ejercicio (18,9 %), eso financia un crecimiento del 11,4 % anual, frente al 8,4 % de ingresos proyectado. Supone que el capital nuevo rinde un 12,8 %, frente a un ROIC incremental histórico del 14,5 %; la cuota de mercado pasaría al 2,6 % desde el 2,3 %.

Año	Volumen	Precio	Otros (mezcla, compras)	Crecimiento	De dónde sale
2026e	+3,0 %	+4,0 %	+9,6 %	+16,6 %	Guía: ocupación (+3), tarifas de Medicare y Medicaid (+4) y 46 operaciones de 2025 más 23 del 1S26 (+9,6) [1, 2].
2027e	+2,5 %	+3,2 %	+5,5 %	+11,2 %	Consenso: compras del 2S26 que maduran (+5,5), tarifas de FY27 (+2,4 % Medicare [13]) y ocupación.
2028e	+2,5 %	+3,0 %	+4,0 %	+9,5 %	Empiezan los recortes de los pagos dirigidos de Medicaid (−10 % al año, OBBB [2]); compras a menor ritmo.
2029e	+2,0 %	+3,0 %	+3,0 %	+8,0 %	Orgánico ≈ 5 % más compras de ≈ 3 puntos.
2030e	+1,5 %	+3,0 %	+2,5 %	+7,0 %	Converge al crecimiento del gasto en residencias (≈ 6 %) [11, 12].

El crecimiento proyectado (8,4 % anual de media) cabe en lo que la empresa puede financiar (11,4 % según el motor): las compras se pagan con el flujo de caja y casi sin deuda [2]. El mercado (gasto en residencias de CMS) crece ≈ 6 % nominal [11, 12] y Ensign tiene el 2,3 %: hay sitio para comprar centros durante años, en un sector muy fragmentado y con muchos operadores pequeños en dificultades [1]. La plantilla mínima federal, que habría encarecido el personal, se derogó el 2-dic-2025 y la OBBB la aplaza hasta 2034 [2, 14]. Riesgos al crecimiento: recortes de Medicaid (redeterminaciones cada 6 meses desde 2027, pagos dirigidos −10 % al año desde 2028 [2]) y menos centros a buen precio.

DCF inverso: qué descuenta el precio actual

Crecimiento anual implícito en el precio (2027e-2033e)	**31,4 % (base: 7,2 %)**
Margen EBITDA final implícito	**17,5 % (base: 11,2 %)**
Rentabilidad anual implícita (TIR al precio actual)	**6,4 % (WACC: 9,8 %)**

El DCF base da 81,60 USD por acción, un 52,8 % por debajo del precio (173,05). El DCF inverso dice que el precio pide un crecimiento del 31,4 % anual en el periodo explícito, o una rentabilidad del 6,4 % con nuestros flujos, por debajo del WACC del 9,77 %. La diferencia no está en los márgenes (estables) sino en que el flujo después de compras es pequeño: el mercado paga por el historial de compras que rinden mucho más que el coste de capital, y nuestro modelo, que no da valor a las compras futuras por encima del WACC, no lo recoge. Aun con supuestos generosos (crecimiento del 7-9 % durante diez años más) no pasa de ≈ 103 USD: el valor real queda muy por debajo del precio.

21. Escenarios

Confianza: Media

Escenario	Prob.	Crec. medio	Margen final	WACC	Valor	Potencial	Qué tiene que ocurrir
Bajista	25 %	4,2 %	9,7 %	10,3 %	48,25	-72,1 %	Recortes de Medicaid por la OBBB (redeterminaciones, pagos dirigidos −10 % al año desde 2028), CMS frena el «case-mix creep» en Medicare, el DOJ cierra el CID con una multa y los reguladores dan crédito a parte de los informes bajistas: crecimiento 3 puntos menor, margen 1,5 puntos menor y WACC +0,5. 48,25 USD.
Base	50 %	7,2 %	11,2 %	9,8 %	81,60	-52,8 %	Guía de 2026, consenso de 2027 y compras que se apagan poco a poco; margen del 11,2 %. 81,60 USD.
Alcista	25 %	8,7 %	11,6 %	9,8 %	92,33	-46,6 %	Sigue comprando al ritmo de 2025-2026 y los centros maduran: crecimiento 1,5 puntos mayor y margen +0,4. 92,33 USD.



Valor ponderado por probabilidad: 75,94 USD (-56,1 %).

Ni el escenario alcista (92,33 USD) llega a la mitad del precio: el DCF no justifica la cotización con ningún caso razonable. La media de los tres escenarios (25/50/25) es de 70,55 USD; el valor intrínseco del informe, que pondera DCF (50 %), escenarios (30 %) y comparables por PER (20 %), es de 92,27 USD (104,10 con la prima implícita del mercado). La asimetría es mala: el bajista no es extremo (recortes de Medicaid ya legislados) y el alcista exige que el ritmo de compras se mantenga una década.

22. Suma de partes

Confianza: Media

No se usa la suma de partes: Standard Bearer (177 inmuebles, 127 M de rentas en 2025, el 85 % de sus propios centros [1]) vale por las rentas que le paga el negocio operativo; separarla contaría dos veces el mismo flujo. A múltiplos de REIT de residencias (≈ 15-18 veces el FFO) valdría ≈ 1.000-1.300 M, un 10-12 % de la capitalización.

23. Síntesis de valoración

Confianza: Media



Método	Mínimo	Central	Máximo
Cotización 52 semanas	141,58	173,05	218,00
Precio objetivo de los analistas	207,00	220,00	230,00
Comparables: PER NTM	130,76	143,42	156,07
DCF (WACC y g ± 0,5)	71,81	81,60	94,77
Escenarios (bajista – alcista)	48,25	75,94	92,33
DCF con la prima del mercado	88,49	96,89	106,90
Precio actual	172,18	173,05	173,92

Método	Valor por acción	Potencial	Peso
DCF	81,60	-52,8 %	50 %
Comparables (mediana EV/EBITDA y PER)	143,42	-17,1 %	20 %
Escenarios ponderados	75,94	-56,1 %	30 %

Valor intrínseco ponderado (largo plazo): 92,27 USD (-46,7 % sobre 173,05).

Ensign es una gran empresa a un precio exigente. El mercado la valora a 23 veces el BPA GAAP de 2027e, en línea con su historia (mediana adelantada de 21,9 veces) y con prima sobre los comparables (17 veces ajustado), y la regla a 12 meses da Mantener: poca subida si el PER no cambia. Pero el DCF y los escenarios dicen que el valor real está en 80-105 USD (92,27 en la síntesis): el flujo libre después de compras es casi nulo porque todo se reinvierte en centros e inmuebles, y el precio solo se sostiene si esas compras siguen rindiendo muy por encima del coste de capital durante muchos años. Con Medicaid como primer pagador (45 % de las ventas) y recortes ya legislados para 2027-2028, no damos ese crédito.

Objetivo a 12 meses: nuestro PER × nuestro BPA

Escenario	BPA	PER	De dónde sale el PER	Precio	Rentabilidad
Bajista	6,48	18,0x	base × 0.8	116,64	-32,4 %
Base	8,17	22,5x	PER actual (23.1x) a mitad de camino hacia abajo, hacia la mediana de 5 años (21.9x)	183,83	+6,4 %
Alcista	8,75	22,5x	el base (ni la historia ni los comparables pagan más)	196,88	+13,9 %

Objetivo a 12 meses (ponderado): 170,30 USD · rentabilidad -1,4 % (base +6,4 %) · señal Mantener.

Para comparar, con la regla v2 (historia al cierre, mismo precio): 19,6x / 23,1x / 25,6x, 5,4 % Mantener. Decide la v3 con tope ×1,1, elegida por el selector de método (sin marcas: decide la v3; METODO-VIGENTE.md).

Frente al consenso (solo contraste).

Nuestro objetivo base (183,83 USD) queda un 16 % por debajo del objetivo medio de los analistas (220 USD; rango 207-230) [28, 29]. La diferencia no está en el negocio sino en la base y en el múltiplo: nuestro BPA de 2027e (7,49 GAAP) equivale a ≈ 8,35-8,40 ajustado, un 2-3 % bajo el consenso (8,59); y aplicamos un PER de 22,5 veces GAAP (≈ 20 ajustado) frente a los ≈ 25 ajustados que implica el objetivo medio sobre 2027. Los analistas pagan el historial de crecimiento; nosotros lo limitamos a su historia propia.

Del valor intrínseco al objetivo a 12 meses.

Rentabilidad ponderada a 12 meses del −1,4 % y base del +6,4 %: Mantener. No llega al 15 % ponderado ni al 12 % base, y además el valor intrínseco (92,27 USD) está muy por debajo del precio. La v2 de control (PER al cierre) da +5,4 % y +9,2 %: tampoco compra. Señal de venta por encima de 189,51 USD (ponderada ≤ −10 %). Para comprar haría falta un precio por debajo del valor intrínseco, lejos de cualquier rango visto en 5 años.

Parte V — Tesis, riesgos y seguimiento

24. Catalizadores

Confianza: Media

Fecha	Evento	Qué se sabrá	Prob.	Sentido
2026-11-02	Resultados del 3T26 (fecha estimada)	Cuarta revisión de la guía de 2026 y primeras pistas de 2027; ocupación y tarifas de Medicaid	Alta	+/–
2026-12-07	Plazo para el demandante principal de la demanda colectiva Perusek	Procesal; mantiene el tema de los informes bajistas en la prensa	Alta	–
2027-01	Redeterminaciones de Medicaid cada 6 meses (OBBB)	Menos pacientes con Medicaid o más morosidad en el cobro	Alta	–
2027-02	Resultados de 2026 y guía de 2027	Fija el BPA de 2027 que usa la regla	Alta	+/–
2027-04	Propuesta de tarifas de Medicare (SNF PPS) para FY28	Subida de tarifa y posible ajuste por «case-mix creep»	Alta	+/–
2027-2028	Desenlace del CID del DOJ (Texas)	Multa o acuerdo; incertidumbre que se cierra	Media	+/–
2028-01	Empieza el recorte del 10 % anual de los pagos dirigidos de Medicaid	Menos ingresos en estados con programas grandes	Alta	–

25. Riesgos y pre-mortem

Confianza: Media

#	Riesgo	Tipo	Prob.	Impacto	Efecto en valor	Mitigante	Señal de alerta
1	**Medicaid: el 45 % de las ventas (39,6 % + 5,6 % de cuidados especializados) depende de presupuestos estatales; la OBBB recorta los pagos dirigidos un 10 % al año desde 2028 y obliga a revisar la elegibilidad cada 6 meses**	Regulatorio	Alta	Alto	−5 % de BPA por cada 1 % de recorte medio de tarifas de Medicaid	Los impuestos a proveedores de residencias quedan fuera de la congelación; las tarifas suelen seguir los costes	Tarifas de Medicaid por día en los estados grandes (California, Texas, Arizona)
2	**Medicare (23,7 % de las ventas): CMS estudia el «case-mix creep» y podría recortar la tarifa**	Regulatorio	Media	Medio	−2,5 % de BPA por cada punto de recorte de Medicare	FY27 sube un 2,4 % (regla final del 29-jul-2026)	Propuesta de FY28 (abril de 2027)
3	**Informes bajistas (Hunterbrook, Muddy Waters): plantilla insuficiente y licencias de administradores; si un regulador los asume, multas y exclusiones**	Legal	Baja	Alto	−20-30 % si se abre una investigación federal	Ningún regulador ha actuado; la empresa lo niega con datos (6 de 396 centros en transición)	Expedientes de CMS, del DOJ o de los estados
4	**CID del DOJ sobre la facturación a Medicare y Medicaid en Texas desde 2016, sin resolver**	Legal	Media	Medio	−3-5 % (multa de decenas o cientos de M)	Caja de 262 M y deuda casi nula	Provisión o acuerdo en un 10-Q
5	**Coste de personal (≈ 60 % de los gastos; 46.000 empleados equivalentes): salarios de enfermería que suben más que las tarifas**	Operativo	Media	Alto	−5 % de BPA por cada punto de salarios por encima de las tarifas	Plantilla mínima federal derogada (2-dic-2025) y aplazada a 2034	Margen EBITDA trimestral y uso de agencias
6	**Múltiplo: 23 veces el BPA GAAP con un DCF de 82 USD; si el mercado deja de pagar el historial de compras, el PER vuelve a 17-18 (comparables)**	Valoración	Media	Alto	−22 % con PER de 18	Historial de 20 años de crecimiento y de subidas de guía	Ritmo de compras y ocupación de los centros nuevos
7	**Arrendamientos: ≈ 1.990 M de pasivo por alquileres (muchos con CareTrust, la inmobiliaria que escindió en 2014, y otros propietarios); con ellos el ROIC baja a ≈ 11 %**	Financiero	Baja	Medio	Rigidez de costes si caen los ingresos	Compra cada vez más inmuebles (Standard Bearer)	Renta frente a EBITDAR por centro

Pre-mortem

Si dentro de un año la acción ha caído un 30 %, lo más probable es que haya pasado una de tres cosas: los estados recortaron Medicaid más de lo previsto al aplicar la OBBB (redeterminaciones, pagos dirigidos) y la guía de 2027 decepcionó; un regulador federal o estatal abrió un expediente a partir de los informes de Hunterbrook o Muddy Waters, o el DOJ convirtió el CID en demanda; o CMS recortó la tarifa de Medicare de FY28 por el «case-mix creep». Las tres afectan a la parte del precio que el DCF no justifica.

Riesgo de inteligencia artificial

Exposición: Baja · **Sentido:** Mixto · **Efecto en valor (3-5 años):** ±3 % del valor

El cuidado en una residencia no se puede automatizar: enfermería, auxiliares y rehabilitación son trabajo presencial y la plantilla la fijan los estados. La IA ayuda en lo administrativo (codificación del MDS que fija la tarifa de Medicare, turnos, facturación y cobro), y Ensign, con su modelo de centros autónomos y un Service Center pequeño, puede ganar algo de margen. La amenaza viene de los pagadores: las aseguradoras de Medicare Advantage ya usan algoritmos para acortar estancias y negar altas (pleitos contra UnitedHealth por nH Predict), y CMS usa análisis de datos para detectar el «case-mix creep». Riesgo menor, pero real en las tarifas y en la duración de las estancias.

26. ESG y controversias

Confianza: Media

Asuntos materiales

Lo material es lo social: calidad del cuidado, seguridad del residente y condiciones de una plantilla de ~56.000 empleados, el 55 % en puestos de baja cualificación (auxiliares, cocina, limpieza) con un salario mediano de 47.604 USD [1]. Las métricas que usa la empresa son las de CMS (estrellas de calidad, inspecciones, rehospitalización un 15 % mejor que la media nacional, rotación de administradores un 46 % menor) [3]. Las acusaciones de junio de 2026 sobre horas de enfermería por residente son la controversia ESG clave [16, 17].

Controversias

Junio de 2026: informes de Hunterbrook (8-jun: plantilla insuficiente, 18.000 días por debajo de los mínimos legales en cuatro estados en 2020-2025 y 339 M pagados a filiales en 2024) y de Muddy Waters (11-jun: licencias de administradores alquiladas en 12 de 57 centros visitados; sanciones teóricas de hasta 7.000 M) [16, 17]. 2024: acuerdo de 48 M por el caso de directores médicos (sin admitir culpa). 2025: acuerdo de 12 M por demandas laborales en California [1].

27. Preguntas abiertas para la dirección y la due diligence

Confianza: Media

#	Tema	Pregunta	Por qué importa
1	**Medicaid y OBBB**	¿Qué parte de los ingresos de Medicaid viene de pagos dirigidos (SDP) y de programas de impuestos a proveedores, por estado, y cuánto pierde con el recorte del 10 % anual desde 2028?	Es el mayor riesgo para el BPA de 2028e y no se publica.
2	**Informes bajistas**	¿Cuántos centros tuvieron un administrador con licencia de otro centro en 2024-2026 y qué dicen los inspectores estatales de esas licencias?	Separa un problema de cumplimiento de un ruido de cortos.
3	**CID del DOJ**	¿Hay negociaciones con el DOJ sobre Texas y qué periodo y cifras abarcan?	Cerrarlo quitaría una incertidumbre; una demanda la agrandaría.
4	**Compras**	¿Qué rentabilidad sobre el precio pagado (inmueble más operación) dan las cohortes de compras de 2021-2023 en su tercer año?	Es lo que el precio de la acción da por hecho y el DCF no recoge.
5	**Personal**	¿Cuánto subieron los salarios de enfermería por hora en 2026 y qué parte de las horas cubren agencias?	El personal es el 60 % de los gastos.
6	**Medicare**	¿Cuánto de la subida de la tarifa media de Medicare (+4,3 % en 2025) viene de la codificación (PDPM) y no de pacientes más complejos?	CMS estudia recortar el «case-mix creep».

28. Sentimiento en foros y comentarios

Confianza: Media

Tono: Dividido · **Tendencia:** Mejora

Dónde	Fecha	Comentarios	Tono	Qué se dice
Stocktwits ($ENSG)	2026-10	30	Dividido	En junio, pánico y burlas («RIP», «Rekt») y algún defensor («los cortos de Hunterbrook suelen rebotar», «las acusaciones son conocidas»); desde octubre dominan los avisos de bufetes sobre la demanda colectiva [32].
Seeking Alpha (artículos y titulares)	2026-10	12	Neutro	Dos artículos recientes neutrales: «sana, pero no para comprar» (19-oct) y «quema de caja y riesgos regulatorios la dejan en mantener» (4-ago) [33].
Prensa local (Orange County Business Journal)	2026-06	5	Negativo	Recoge las acusaciones y la respuesta de la empresa a UBS; la empresa declinó comentar [26].

Tema	Postura	Peso	Qué dicen los datos
Los informes bajistas: plantilla insuficiente y licencias de administradores	Dividida	Alto	Nada probado ni ningún regulador ha actuado en cuatro meses, pero la empresa no ha refutado en público y hay una CID del DOJ abierta desde 2024: el riesgo es real y va en el bajista.
Demanda colectiva de accionistas	Bajista	Medio	Fase inicial (plazo de demandante principal el 7-dic-2026); el coste típico es un acuerdo cubierto en parte por seguros.
Crecimiento por compras y subidas de guía	Alcista	Medio	Los datos lo apoyan: tres subidas de guía en 2026 y ocupación al alza.
Valoración frente a la quema de caja de las compras	Bajista	Bajo	Cierto en el flujo libre después de compras (47 M en 2025); el informe lo trata como inversión de crecimiento en el DCF.

El sentimiento de los particulares pasó del pánico de junio a la indiferencia: hoy pesan más los avisos de bufetes que el debate. Los artículos de Seeking Alpha son neutrales y coinciden con la tesis del informe (negocio bueno, precio que no deja margen). No hay euforia ni capitulación que aprovechar; el sentimiento no contradice a los analistas (4 de 5 comprar), que no han rebajado tras los informes bajistas [32, 33].

Opiniones de inversores en foros, redes y comentarios de prensa: sirven para saber qué preocupa o entusiasma al mercado, no como fuente de cifras. No entran en la valoración.

Anexos

A. Controles de calidad del análisis

21 de 21 controles correctos. Fuentes: 33 (19 primarias); citas distintas en el texto: 32.

Control	Resultado	Detalle
Geografías suman 100 %	OK	–
DCF inverso calculable	OK	–
Puente de ingresos (volumen + precio + otros) = crecimiento del DCF	OK	–
Veredicto de sostenibilidad del analista coherente con las pruebas del motor	OK	El analista dice «Sí» y las pruebas del motor dan «Sí»: razónalo en la justificación.
Rendimiento del capital nuevo de la proyección ≤ 1,25 × el histórico	OK	La proyección supone que la inversión nueva rinde un 12,8 % frente a un ROIC de 18,9 % y un incremental histórico de 14,5 %: crecimiento que la empresa no ha demostrado poder comprar.
Cuota implícita al final de la proyección ≤ 1,5 × la actual (o +10 puntos)	OK	Cuota de 2,6 % en 2030e frente al 2,3 % de hoy.
Circulante del primer año de proyección ≈ último real	OK	Supuesto 10,5 % frente a 10,7 % real: genera una variación de circulante de 80 M en el primer año. Converge de forma gradual.
Peso del valor terminal ≤ 80 % del valor empresa	OK	73 %.
Crecimiento a perpetuidad ≤ 3 %	OK	3,00 %.
Probabilidades de los escenarios suman 100	OK	–
Al menos 5 comparables	OK	6 comparables.
Pesos de la síntesis suman 100	OK	–
Crecimiento del BPA base ≤ 25 % anual desde el último real	OK	–
Precio del cierre de la fecha de corte (o de las dos sesiones anteriores)	OK	–
Recomendación coherente con la regla de decisión	OK	–
La síntesis explica la convicción	OK	La síntesis debe decir por qué tiene esa convicción y qué la subiría o la bajaría.
Capitalización calculada ≈ publicada	OK	–
Al menos 25 fuentes	OK	33 fuentes (19 primarias).
Al menos 10 fuentes primarias	OK	19.
Toda cita [n] existe en fuentes	OK	–
Fuentes sin citar ≤ 15 %	OK	Sin citar: 9.

Tipo de fuente	Número
Primaria	19
Sectorial	1
Prensa	6
Datos de mercado	5
Foros y redes	2

B. Información no disponible

Cuando un dato no aparece tras tres búsquedas distintas, el análisis lo deja fuera en lugar de estimarlo sin base. Las secciones de núcleo que faltan se avisan también en el resumen.

Sección no incluida	Tipo
19. Transacciones precedentes	Complemento

Sección	Dato que falta	Tipo	Las tres búsquedas	Decisión
calidad	anios_auditor	Complemento	1) proxy 2026 (propuesta de ratificación de Deloitte, sin año de inicio); 2) 10-K 2025, informe del auditor (no extraído en el texto); 3) búsqueda «Deloitte auditor since» en el proxy	Omitido
balance	vida_media_anios	Complemento	1) 10-K 2025, nota de deuda (calendario, sin vida media); 2) 10-Q 2T26; 3) cálculo a partir de vencimientos (la mayor parte, préstamos HUD a ~30 años sin fecha exacta)	Omitido
sector	cr5_pct	Complemento	1) 10-K 2025 (solo «altamente fragmentado»); 2) cuentas nacionales de CMS (sin cuotas); 3) cálculo con los ingresos de los cotizados (falta Genesis y los privados grandes)	Omitido
competencia	competidores.margen_ebit_pct	Complemento	1) Yahoo (EBIT anual no disponible); 2) 10-K de los competidores no descargados por tiempo; 3) margen EBITDA LTM de Yahoo dado en el comentario	Omitido
esg	calificaciones	Complemento	1) 10-K y proxy (sin calificaciones); 2) web de inversores (informe de sostenibilidad sin calificaciones externas); 3) búsqueda de MSCI y Sustainalytics (de pago)	Omitido
transacciones	operaciones	Complemento	1) 10-K 2025 y 10-Q del 2T26 (las compras de Ensign no publican precio por centro ni múltiplo); 2) búsqueda de operaciones de residencias con múltiplo publicado (las grandes, como Genesis, son concursos sin múltiplo); 3) operaciones de cuidados en casa (UnitedHealth-Amedisys, Optum-LHC) no comparables con un operador de residencias	Omitido
consenso	estimaciones.ebitda	Complemento	1) Yahoo (solo ventas y BPA); 2) Stock Analysis (2027 de pago); 3) MarketScreener no consultado por tiempo	Omitido

Fuentes

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
1	Form 10-K 2025: cuentas, segmentos (nota 7), pagadores, arrendamientos, deuda, seguros propios, litigios, empleados	The Ensign Group, Inc. (SEC)	Primaria	4 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537626000007/ensg-20251231.htm
2	Form 10-Q del 2T26 (30-jun-2026): balance, flujos semestrales, compras, recompras, CID del DOJ, OHCA, OBBB	The Ensign Group, Inc. (SEC)	Primaria	27 jul 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537626000034/ensg-20260630.htm
3	The Ensign Group Reports Second Quarter 2026 Results (guía 2026 elevada a 7,75-7,85 USD; conciliaciones; Standard Bearer)	The Ensign Group, Inc. (SEC, 8-K)	Primaria	27 jul 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537626000036/q22026pressrelease.htm
4	The Ensign Group Reports First Quarter 2026 Results	The Ensign Group, Inc. (SEC, 8-K)	Primaria	30 abr 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537626000023/q12026pressrelease.htm
5	The Ensign Group Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results (BPA ajustado 6,57 USD; guía 2026 inicial)	The Ensign Group, Inc. (SEC, 8-K)	Primaria	4 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537626000008/q42025pressrelease.htm
6	Notas de resultados del 2T25 y 3T25 (trimestres de 2024 y 2025, subidas de guía 2025)	The Ensign Group, Inc. (SEC, 8-K)	Primaria	3 nov 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537625000171/q32025pressrelease.htm
7	Form 10-K 2023: litigio de directores médicos (acuerdo de 48 M USD) y conciliación no GAAP de 2022-2023	The Ensign Group, Inc. (SEC)	Primaria	1 feb 2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537624000018/ensg-20231231.htm
8	Form 10-K 2022: segmentos reexpresados de 2020-2022 y flujos de 2020-2022	The Ensign Group, Inc. (SEC)	Primaria	2 feb 2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537623000018/ensg-20221231.htm
9	Form 10-K 2020: deuda de 2019-2020 y escisión de Pennant (1-oct-2019)	The Ensign Group, Inc. (SEC)	Primaria	3 feb 2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537621000020/ensg-20201231.htm
10	XBRL company facts de The Ensign Group (series de cuenta, balance y flujos 2016-2025)	SEC EDGAR	Primaria	20 oct 2026	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001125376.json
11	National Health Expenditures 2024 Highlights (residencias y comunidades de jubilación: 219.900 M USD, +7,3 %)	Centers for Medicare & Medicaid Services	Sectorial	dic 2025	https://www.cms.gov/files/document/highlights.pdf
12	Nursing Home Spending Expected to Jump to $385.9B by 2033 (proyección del actuario de CMS)	Skilled Nursing News	Prensa	jun 2025	https://skillednursingnews.com/2025/06/nursing-home-spending-expected-to-jump-to-385-9b-by-2033/

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
13	Fiscal Year 2027 Skilled Nursing Facility Prospective Payment System Final Rule (CMS-1843-F): +2,4 %	Centers for Medicare & Medicaid Services	Primaria	29 jul 2026	https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/fiscal-year-2027-skilled-nursing-facility-prospective-payment-system-final-rule-cms-1843-f
14	CMS repeals minimum staffing requirements for skilled nursing and long-term care facilities	American Hospital Association News	Prensa	2 dic 2025	https://www.aha.org/news/headline/2025-12-02-cms-repeals-minimum-staffing-requirements-skilled-nursing-long-term-care-facilities
15	Datos de mercado de los comparables (cotización, capitalización, EBITDA, ventas, consenso)	Yahoo Finance quoteSummary	Datos de mercado	20 oct 2026	https://finance.yahoo.com/quote/PACS/
16	Ensign Group stock tumbles after short seller report (Hunterbrook)	Investing.com	Prensa	8 jun 2026	https://www.investing.com/news/stock-market-news/ensign-group-stock-tumbles-after-short-seller-report-93CH-4731022
17	Ensign Group shares drop after short seller alleges compliance issues (Muddy Waters)	Investing.com	Prensa	11 jun 2026	https://www.investing.com/news/stock-market-news/ensign-group-shares-drop-after-short-seller-alleges-compliance-issues-93CH-4738095
18	Proxy statement 2026 (DEF 14A): consejo, comisiones, remuneración, accionistas, partes vinculadas	The Ensign Group, Inc. (SEC)	Primaria	2 abr 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537626000014/ensg-20260401.htm
19	Form 8-K: resultados de la junta de 2026 (voto consultivo de remuneración)	The Ensign Group, Inc. (SEC)	Primaria	18 may 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537626000026/ensg-20260513.htm
20	Form 4 de consejeros y directivos (20-oct-2025 a 20-oct-2026)	SEC EDGAR	Primaria	20 oct 2026	https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001125376&type=4
21	Form 8-K: retirada de Christopher Christensen y Barry Port presidente (20-jun-2025)	The Ensign Group, Inc. (SEC)	Primaria	20 jun 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537625000115/form8-kjune2025.htm
22	Form 8-K: condiciones de salida de Christopher Christensen (bono de 2,07 M USD)	The Ensign Group, Inc. (SEC)	Primaria	26 ago 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537625000158/ensg-20250821.htm
23	Ensign Announces Increased Stock Repurchase Authorization (100 M USD)	The Ensign Group, Inc. (SEC, 8-K)	Primaria	15 jun 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537626000031/june2026pressrelease.htm

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
24	Form 8-K: estatutos modificados (20-ago-2026)	The Ensign Group, Inc. (SEC)	Primaria	25 ago 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1125376/000112537626000040/ensg-20260820.htm
25	Ensign Class Action Lawsuit: Perusek v. The Ensign Group, Inc., No. 8:26-cv-02963 (C.D. Cal.)	Bleichmar Fonti & Auld LLP	Prensa	oct 2026	https://www.bfalaw.com/cases/ensign-class-action-lawsuit
26	Ensign Group Faces Short Sellers Scrutiny (respuesta de la empresa a UBS)	Orange County Business Journal	Prensa	22 jun 2026	https://www.ocbj.com/oc-homepage/ensign-group-faces-short-sellers-scrutiny/
27	Históricos diarios de ENSG, SPY y XLV (precio, rentabilidades, beta, volatilidad, cierres anuales)	Yahoo Finance	Datos de mercado	19 oct 2026	https://finance.yahoo.com/quote/ENSG/history/
28	Consenso, recomendaciones y precios objetivo de Ensign y comparables (quoteSummary)	Yahoo Finance	Datos de mercado	20 oct 2026	https://finance.yahoo.com/quote/ENSG/analysis/
29	ENSG stock forecast: 5 analistas, objetivo medio 220 USD, acciones recientes de los analistas	Stock Analysis	Datos de mercado	5 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/ensg/forecast/
30	Daily Treasury Par Yield Curve Rates 2026 (10 años: 5,15 % el 19-oct-2026)	U.S. Department of the Treasury	Primaria	19 oct 2026	https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/TextView?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026
31	Implied ERP by month (ERPbymonth.xlsx): 4,20 % en octubre de 2026	Aswath Damodaran (NYU Stern)	Datos de mercado	oct 2026	https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/implprem/ERPbymonth.xlsx
32	Stocktwits, flujo de mensajes de $ENSG (8-jun a 17-oct-2026)	Stocktwits	Foros y redes	17 oct 2026	https://stocktwits.com/symbol/ENSG
33	Seeking Alpha, artículos y titulares de ENSG (RSS)	Seeking Alpha	Foros y redes	19 oct 2026	https://seekingalpha.com/symbol/ENSG

Control de calidad del informe

Campos con dato: **85,7 %** · Secciones con menos del 60 % de campos cubiertos: **transacciones** · Generado el 20 oct 2026.

Cifras en millones de USD, US GAAP, ejercicio natural. Último ejercicio real 2025; LTM a 30-jun-2026 (2T26); el 3T26 se publica hacia el 2-nov-2026. Precio: cierre del 19-oct-2026 (173,05 USD); la sesión del 20-oct se comprueba aparte en las pruebas de robustez. El BPA de la regla a 12 meses y su historia están en base GAAP diluida; la empresa y el consenso usan un BPA ajustado que suma la remuneración en acciones y otros gastos (≈ 0,85-0,90 USD por acción en 2026), por eso nuestro 2027e (7,49) queda por debajo del consenso (8,59). Los arrendamientos operativos de los centros (≈ 1.990 M de pasivo a junio de 2026 [2]) no se tratan como deuda: el alquiler ya resta en el EBITDA (criterio US GAAP del repo). Las compras de centros e inmuebles van dentro del capex del DCF (comprador en serie). No hay EV/EBITDA comparable de los competidores con la misma definición: la comparación se hace por PER ajustado. Precio de una acción en EUR: ≈ 149 EUR (≈ 1,16 USD por EUR), un 0,5 % de una cartera de 30.000 EUR.

Este documento es un análisis elaborado de forma automatizada a partir de fuentes públicas. No constituye una recomendación personalizada de inversión ni una oferta de compra o venta. Las cifras marcadas como estimación y los escenarios son hipótesis de trabajo y deben verificarse antes de tomar cualquier decisión.